

Monograf

DETEKSI DINI RISIKO PERDARAHAN POSTPARTUM

Dhiana Setyorini
Intim Cahyono
Nur Hasanah



Buku Monograf
DETEKSI DINI RISIKO
PERDARAHAN POSTPARTUM

Dr. Ns. Dhiana Setyorini, M.Kep., Sp.Mat.
Intim Cahyono, S,Kep., Ns. M.Kes.
Nur Hasanah, SKM., M.Kes.



Buku Monograf
DETEKSI DINI RISIKO
PERDARAHAN POSTPARTUM

Dr. Ns. Dhiana Setyorini, M.Kep., Sp.Mat.
Intim Cahyono, S,Kep., Ns. M.Kes.
Nur Hasanah, SKM., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Achmad Faisal

ISBN: 978-634-7294-76-0
Cetakan Pertama: Agustus, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
All Right Reserved
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

Instagram @bimbel.optimal
Tiktok @maskokooo
www.optimaluntuknegeri.com
Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



Prakata

Assalamu'alaikum wr wb.

Perdarahan Postpartum adalah salah satu penyebab kematian ibu tertinggi di Indonesia, perlu alat deteksi dini risiko perdarahan postpartum yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader dan ibu hamil untuk mencegah terjadinya kecacatan dan kematian pada ibu akibat perdarahan postpartum.

Angka kematian ibu yang tinggi merupakan masalah kesehatan dan sosial, dan hal ini merupakan masalah yang sangat membutuhkan perhatian, karena ibu adalah yang melahirkan generasi penerus bangsa sehingga kesehatan ibu saat hamil harus mendapat perhatian yang lebih baik.

Kartu Skor Deteksi Dini Risiko Perdarahan Postpartum (KSPPP) adalah kartu deteksi dini terjadinya risiko perdarahan postpartum pada ibu bersalin yang dapat digunakan oleh tenaga kesehatan dan masyarakat/kader. Diharapkan dengan menggunakan KSPPP ini ibu hamil dapat segera terdeteksi bila ada risiko mengalami perdarahan postpartum dan segera mendapatkan perawatan sehingga tidak mengalami perdarahan postpartum dan angka kematian ibu dapat diturunkan.

Puji Syukur kepada Allah Swt karena atas limpahan rahmadNyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku Deteksi Dini Risiko Perdarahan Postpartum.Terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan pada penulis sehingga buku Deteksi Dini Risiko Perdarahan Postpartum ini dapat tersusun.

Semoga buku ini bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil dan kesehatan semua perempuan.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Mei, 2025

Dhiana Setyorini
Penulis Utama

Daftar Isi

Prakata.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB 1 Perdarahan Postpartum Penting untuk Dipahami.....	1
BAB 2 Apa yang Terjadi pada Tubuh Pasca Melahirkan?.....	4
A. Menenal Masa Postpartum	4
B. Perubahan Sistem Reproduksi saat Postpartum.....	14
C. Pengertian Perdarahan Postpartum	19
D. Penyebab Perdarahan Postpartum	20
E. Jenis-jenis Perdarahan Postpartum yang Perlu Diketahui.....	23
F. Siapa yang Berisiko Mengalami Perdarahan Postpartum?.....	25
BAB 3 Mengungkap Penyebab Perdarahan Pasca Melahirkan	28
A. Menenal Penyebab Utama: Atonia Uteri.....	28
B. Proses Terjadinya Perdarahan Postpartum.....	33
C. Gejala Klinis Perdarahan Postpartum.....	34
D. Cara Mengetahui Adanya Perdarahan Postpartum	35
E. Langkah Pencegahan yang Efektif	36
F. Strategi Pendekatan Risiko	37
G. Risiko Terjadinya Perdarahan Postpartum	39
BAB 4 Menenal Kartu Skor untuk Deteksi Dini Perdarahan Postpartum.....	41
A. Kartu Skor Deteksi Dini Risiko Perdarahan Postpartum (KSPPP).....	41

B. Langkah Mudah Mengisi Kartu Skor KSPPP	43
C. Menentukan Tingkat Risiko dengan Cepat.....	51
D. Mengartikan Hasil Kartu Skor KSPPP	51
BAB 5 Mudah dan Cepat: Aplikasi Digital KSPPP	53
A. Mengenal Aplikasi Digital Deteksi Risiko Perdarahan	53
B. Panduan Penggunaan Aplikasi KSPPP secara Praktis.....	54
BAB 6 Mengelola Perdarahan dengan Sistem Rujukan yang Efektif	60
A. Pengertian Sistem Rujukan dalam Penanganan Perdarahan	60
B. Langkah Pencegahan Sebelum Merujuk.....	61
C. Mengenal Rujukan Terencana	62
D. Manfaat Sistem Rujukan Terencana bagi Ibu dan Bayi.....	62
BAB 7 Langkah Selanjutnya untuk Masa Depan Lebih Aman	64
Daftar Pustaka	66
Glosarium	69
Profil Penulis.....	71



BAB 1

Perdarahan Postpartum Penting untuk Dipahami

Melahirkan merupakan momen istimewa yang dinanti setiap ibu dan keluarga. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada risiko kesehatan yang serius yang sering kali terlupakan, yaitu perdarahan setelah melahirkan atau dikenal dengan perdarahan postpartum. Kondisi ini adalah salah satu situasi darurat medis yang bisa dialami setiap ibu setelah melahirkan, baik secara normal maupun operasi.

Secara sederhana, perdarahan postpartum didefinisikan sebagai kehilangan darah sebanyak 500 ml atau lebih setelah bayi lahir. Dalam beberapa kasus, jumlah darah yang hilang bahkan bisa mencapai lebih dari 1.000 ml, yang dapat menyebabkan syok dan kematian jika tidak ditangani segera. Karena itulah, memahami dan mendeteksi risiko perdarahan sejak masa kehamilan menjadi langkah penting untuk menyelamatkan nyawa ibu.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, perdarahan setelah melahirkan masih menjadi penyebab utama kematian ibu. Di negara berkembang, lebih dari seperempat kematian ibu disebabkan oleh kondisi ini. Bahkan, di beberapa daerah, angkanya bisa mencapai lebih dari 30 persen dari seluruh kematian ibu. Hal ini menunjukkan

betapa pentingnya kesiapsiagaan tenaga kesehatan dan keluarga dalam menghadapi kemungkinan terburuk (WHO, 2023). Risiko perdarahan postpartum dapat meningkat pada ibu hamil yang mengalami anemia, tekanan darah tinggi, atau memiliki riwayat komplikasi pada kehamilan sebelumnya. Selain itu, kondisi seperti persalinan yang lama, kehamilan kembar, atau ukuran janin yang besar juga dapat memperbesar kemungkinan terjadinya perdarahan.

Sayangnya, tidak semua ibu menyadari bahwa mereka memiliki faktor risiko tersebut. Banyak dari mereka yang merasa kehamilannya baik-baik saja, padahal sebenarnya ada tanda-tanda yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya deteksi dini yang sistematis agar ibu hamil yang berisiko dapat mendapatkan perhatian lebih sejak awal.

Salah satu cara yang efektif untuk melakukan deteksi dini adalah melalui penggunaan alat bantu berupa kartu skor risiko perdarahan post partum. Kartu ini dirancang untuk membantu bidan, perawat, maupun kader kesehatan dalam mengidentifikasi ibu hamil yang memiliki kemungkinan mengalami perdarahan.

Dengan cara ini, mereka bisa memberikan edukasi, perawatan, dan rujukan yang sesuai sebelum terjadi komplikasi. Deteksi dini bukan hanya tanggung jawab tenaga medis. Keluarga, terutama suami dan orang terdekat ibu hamil, juga memiliki peran penting. Dengan memahami faktor-faktor risiko dan tanda-tanda bahaya, keluarga bisa turut serta menjaga keselamatan ibu selama kehamilan hingga masa setelah persalinan.

Melalui buku ini, pembaca akan diajak untuk mengenali, memahami, serta menerapkan langkah-langkah praktis dalam deteksi dini risiko perdarahan postpartum. Harapannya, setiap ibu dapat menjalani kehamilan yang lebih aman, proses persalinan yang lebih terkontrol, serta meminimalisir risiko serius yang bisa mengancam jiwa ibu.

BAB 2

Apa yang Terjadi pada Tubuh Pasca Melahirkan?

A. Mengenal Masa Postpartum

Apa itu Masa Postpartum?

Masa postpartum atau masa puerperium adalah masa setelah persalinan atau setelah lahirnya plasenta dan berakhir ketika alat kandungan kembali seperti semula atau seperti sebelum hamil, yang berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari. Selama masa puerperium, organ reproduksi secara perlahan akan mengalami perubahan seperti keadaan sebelum hamil. Pulihnya alat reproduksi atau perubahan alat reproduksi disebut involusi (Dhiana dkk, 2023)

"Postpartum" menggambarkan waktu segera setelah kelahiran bayi dan keluarnya plasenta dari rahim, yang berlangsung selama sekitar enam minggu. Organ-organ yang berhubungan dengan rahim mengalami perubahan, termasuk cedera dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kelahiran, dan juga mengalami penyembuhan sepanjang waktu tersebut.

Setelah melahirkan, seorang ibu akan memasuki masa yang disebut fase postpartum (puerperium), yang biasanya berlangsung sekitar

enam minggu. Sebagai gambaran, dibutuhkan waktu tiga bulan agar seluruh organ genital kembali ke kondisi normal sebelum hamil. Dapat dibayangkan bahwa darah akan mulai mengalir keluar dalam beberapa hari dalam masa setelah melahirkan yang paling singkat, yang mana bisa dikatakan sangat singkat. Sedangkan masa postpartum yang paling lama adalah empat puluh hari (Dhiana dkk, 2023)

Tahapan Masa Postpartum

Postpartum atau masa postpartum dibagi menjadi 3 tahap, yaitu:

1. Postpartum dini

Postpartum dini adalah masa kembalinya alat reproduksi/pemulihan awal dimana ibu diperbolehkan untuk berdiri dan berjalan-jalan bagi ibu yang tidak mengalami komplikasi. Dapat dilakukan dalam 6 jam pertama setelah kala IV

2. Postpartum intermedial

Suatu masa kembalinya alat reproduksi/pemulihan dimana alat reproduksi secara berangsur-angsur akan kembali ke keadaan sebelum hamil. Dan memerlukan waktu selama kurang lebih enam minggu atau 42 hari.

3. Remote Postpartum

Masa yang diperlukan untuk kembalinya/pulih dan sehatnya ibu setelah melahirkan kekeadaan sempurna terutama bila ibu selama hamil atau waktu persalinan mengalami komplikasi.

Mengenal Lochea (Darah Nifas)

1. Lochea kruenta/rubra

Terjadi pada hari 1-2 postpartum, terdiri dari darah segar bercampur sisa- sisa selaput ketuban, verniks kaseosa, rambut lanugo, sel- sel desidua, dan mekoneum.

2. Lochea sanguinolenta

Terjadi pada hari ke 3-7 postpartum, terdiri dari darah bercampur lendir.

3. Lochea serosa

Lochea yang terjadi setelah 1 minggu postpartum, cairan berwarna agak kekuningan,

4. Lochea alba

Terjadi 2 minggu setelah melahirkan dan merupakan cairan putih, Normalnya lochea agak berbau amis, kecuali bila terjadi infeksi pada jalan lahir, baunya akan berubah menjadi berbau busuk.

**Tanda –Tanda Bahaya yang Perlu Diwaspadai
Saat Masa Postpartum**

Selama masa nifas, ada beberapa tanda bahaya yang harus segera dikenali dan ditangani oleh tenaga kesehatan:

1. Perdarahan hebat atau terjadi peningkatan perdarahan secara tiba-tiba
2. Keluarnya cairan vaginal yang berbau busuk.
3. Rasa nyeri di perut bagian bawah atau punggung nyeri epigastrium.
4. Masalah penglihatan, sakit kepala yang terus menerus..
5. Pembengkakan pada wajah dan tangan
6. Rasa sakit sewaktu buang air seni, atau merasa tidak enak badan.
7. Payudara yang memerah panas dan/atau sakit, demam muntah.
8. Hilangnya selera makan untuk waktu yang berkepanjangan.
9. Rasa sakit. warna merah, bengkak pada kaki.
10. Sangat sedih dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri atau bayinya.
11. Lemah dan letih atau nafas terengah-engah.

Memahami Kebutuhan Dasar Ibu Masa Postpartum

1. Kebutuhan nutrisi

Nutrisi pada masa postpartum memainkan peran penting untuk mendukung pemulihan kesehatan ibu serta produksi Air Susu Ibu (ASI). Seorang ibu membutuhkan asupan nutrisi berupa karbohidrat, protein, zat besi, vitamin, dan mineral yang cukup. Nutrisi ini sangat dibutuhkan untuk memperlancar proses produksi ASI, mendukung proses ekskresi, dan mencegah anemia yang umum terjadi pada masa postpartum.

2. Kebutuhan ambulasi

Ambulasi atau mobilisasi dini setelah persalinan penting untuk mempercepat pemulihan fisik ibu. Ambulasi biasanya dapat dimulai dua jam setelah melahirkan, dilakukan secara perlahan dan bertahap, dimulai dengan berbaring miring ke kanan atau kiri, kemudian perlahan berangsur-angsur bergerak ke posisi duduk, berdiri, hingga berjalan ringan. Ambulasi yang teratur dan hati-hati membantu mencegah komplikasi seperti trombosis vena dalam.

3. Kebersihan diri

Alasan perlunya meningkatkan kebersihan diri terutama vagina pada masa postpartum adalah:

- a. Adanya lochea yang keluar dari vagina selama masa postpartum.
- b. Letak vagina berdekatan dengan saluran buang air kecil (meatus eksternus uretrae) dan buang air besar (anus). Saluran ini merupakan saluran pembuangan dan banyak mengandung mikroorganisme patogen.
- c. Sebagai akibat proses persalinan bisa saja terjadi luka/trauma di daerah perineum dan kemungkinan disaat persalinan ibu mengeluarkan kotoran dan terkena perineum yang terluka sehingga dapat terjadi infeksi.

- d. Vagina akan mudah dimasuki mikroorganisme yang dapat menjalar ke rahim karena vagina merupakan organ yang terbuka dan mudah dimasuki mikroorganisme.
4. Kebutuhan istirahat dan tidur
Ibu postpartum memerlukan istirahat yang cukup, paling tidak istirahat tidur yang dibutuhkan ibu postpartum sekitar 8 jam pada malam hari dan 1 jam pada siang hari. Pada minggu minggu awal sekitar tiga hari pertama ibu merasa sulit untuk dapat istirahat akibat menumpuknya kelelahan karena proses persalinan dan nyeri yang timbul pada luka perineum. Secara teoritis, pola tidur akan kembali mendekati normal dalam 2 sampai 3 minggu setelah persalinan.
5. Kebutuhan perawatan payudara
Perawatan payudara sebaiknya telah dimulai sejak kehamilan agar papila mammae lemas, tidak keras dan kering sebagai persiapan untuk menyusui bayinya.
6. Latihan senam postpartum
Untuk mempercepat pulihnya kembali alat reproduksi dan untuk meningkatkan kesehatan ibu postpartum maka ibu memerlukan atau membutuhkan latihan - latihan tertentu seperti senam postpartum dan lain lain.

Komplikasi pada Masa Postpartum dan Penanganannya

1. Infeksi masa postpartum
Infeksi postpartum merupakan komplikasi serius yang perlu segera dikenali dan ditangani. Infeksi ini biasanya ditandai dengan peningkatan suhu tubuh hingga 38°C atau lebih, muncul pada hari kedua hingga kesepuluh setelah melahirkan. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko infeksi postpartum antara lain diabetes, preeklamsia, anemia, persalinan lama, pecah ketuban dini, serta kurangnya kebersihan selama proses persalinan. Pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan selama

persalinan, menghindari tindakan invasif yang berlebihan, dan memberikan perawatan optimal pada luka persalinan.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya infeksi pasca melahirkan:

a. Penyebab infeksi postpartum

Kuman bisa masuk ke dalam rahim melalui berbagai cara, antara lain kuman eksogen yang berasal dari luar, kuman autogen yang berasal dari bagian tubuh lain, dan kuman endogen yang berasal dari jalan lahir itu sendiri. Sebagai penghuni jalan lahir pada umumnya, streptokokus anaerobik bukanlah patogen; namun, penyakit ini merupakan penyebab paling umum dari kondisi ini.

b. Cara terjadinya infeksi postpartum

Kemungkinan penyebab penyakit ini antara lain tangan pemeriksa atau asisten, infeksi yang ditularkan melalui droplet, virus nosokomial, dan koitus.

c. Faktor predisposisi infeksi postpartum: Hal ini mencakup penyakit seperti pendarahan berlebihan, diabetes, preeklamsia, kelaparan, dan anemia, yang semuanya berdampak pada penurunan daya tahan tubuh pasien. Adanya kelelahan, di samping infeksi lain, seperti pneumonia, penyakit jantung, dan sebagainya, serta proses persalinan yang bermasalah, seperti persalinan lama atau terhambat, terutama dengan ketuban pecah berkepanjangan, korioamnionitis, persalinan traumatis, proses pencegahan infeksi yang tidak memadai, dan manipulasi yang berlebihan, prosedur bedah obstetri baik secara vaginal maupun perabdominal, serta sisasisanya. episiotomi atau laserasi, pembekuan darah di rongga rahim, dan plasenta serta selaput ketuban merupakan komplikasi potensial.

d. Pencegahan Infeksi Postpartum

- 1) Masa kehamilan: mengurangi atau mencegah faktor risiko.
- 2) Selama persalinan
 - a) Penting untuk menghindari melahirkan dalam waktu yang terlalu lama dan menghindari pecahnya ketuban dalam jangka waktu yang lama
 - b) Penting juga untuk memastikan bahwa persalinan diselesaikan dengan trauma sesedikit mungkin.
 - c) Segala luka pada jalan lahir yang disebabkan oleh prosedur vagina atau perut dibersihkan, dijahit sebaik mungkin, dan steril.
 - d) Penting untuk mencegah pendarahan hebat, dan jika ada darah yang hilang harus segera diganti dengan transfusi darah.
 - e) Seluruh staf di ruang bersalin harus memakai masker untuk menutupi hidung dan mulut.
 - f) Alat dan kain yang digunakan saat melahirkan adalah steril.
 - g) Penting untuk menghindari komplikasi pascapersalinan yang berulang.
- 3) Selama masa postpartum luka-luka dirawat dan meningkatkan status imunitas.

2. Masalah payudara

Jika payudara tidak disusukan dengan benar, jika puting mengalami iritasi, jika bra terlalu ketat, jika pola makan ibu buruk, kurang istirahat, dan jika mengalami anemia, maka payudara menjadi merah, panas, dan nyeri. Payudara juga bisa terasa nyeri jika tidak dirawat dengan benar.

a. Mastitis

Istilah "mastitis" mengacu pada peradangan yang terjadi pada payudara. Meskipun mastitis dapat muncul kapan saja selama

fase menyusui, kejadian paling umum dari kondisi ini terjadi antara hari kesepuluh dan kedua puluh delapan setelah kelahiran. Mastitis juga bisa muncul kapan saja sepanjang fase menyusui.

- 1) Penyebab: Payudara bengkak akibat kurang menyusui, bra terlalu ketat, puting nyeri hingga infeksi, asupan nutrisi rendah, dan anemia merupakan gejala infeksi payudara.
 - 2) Gejala: payudara yang bengkak dan nyeri, payudara yang tampak merah di seluruh atau di lokasi tertentu, payudara yang terasa keras dan ada benjolan, demam, dan nyeri secara keseluruhan merupakan gejala dari kondisi ini. Pengobatannya berupa mengompres payudara dengan air hangat, pemberian obat analgesik untuk meredakan nyeri, pemberian antibiotik untuk mengatasi infeksi, memperbolehkan bayi mulai menyusui dari payudara yang meradang, menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya, menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan bergizi, dan istirahat khusus.
- b. Abses payudara
- Ada perbedaan antara mastitis dan abses payudara. Jika mastitis tidak diobati dengan tepat, hal ini dapat menyebabkan berkembangnya abses payudara, yang pada akhirnya membuat infeksi menjadi lebih parah.
- 1) Gejala: Benjolan pada payudara ibu terasa lunak karena berisi nanah, payudara ibu secara keseluruhan lebih mengkilat dan merah, serta nyeri pada payudara ibu tampak sangat hebat.
 - 2) Penanganan: Cara menyusui yang benar, mengompres payudara bergantian dengan air hangat dan dingin, tetap menyusui bayi, mulai menyusui pada payudara yang sehat, berhenti menyusui pada payudara yang mengalami abses selama ASI sudah diperah, pemberian antibiotik jika abses

semakin parah dan mengeluarkan nanah, serta konsultasi ke dokter. Jika situasinya tidak membaik, temui ahlinya.

c. Putting susu lecet

Putting nyeri dapat disebabkan oleh beberapa faktor: puting pecah-pecah dan kerusakan pada puting yang terjadi saat menyusui. Dalam kurun waktu empat puluh delapan jam, pecah pecah pada puting mungkin akan sembuh dengan sendirinya.

- 1) Penyebab: Cara menyusui yang tidak tepat, puting susu terkena sabun saat ibu membersihkan puting, penularan moniliasis dari mulut bayi ke puting susu ibu, adanya lidah bayi yang pendek, dan cara penghentian ASI yang tidak tepat.
- 2) Penatalaksanaan: Pelajari penyebab puting susu lecet. Pada puting yang normal atau sedikit lecet, ibu harus mulai menyusui. Jika ingin membersihkan puting susu, sebaiknya hindari penggunaan sabun, krim, atau alkohol. Tingkatkan frekuensi menyusui menjadi antara delapan dan dua belas kali per dua puluh empat jam. Sebelum mulai menyusui, periksa apakah sudah berada dalam postur tubuh yang benar. Putting susu yang nyeri karena lecet harus diobati dengan diolesi ASI setelah bayi disusui hingga waktu menyusui lagi. Tunggu sampai mengering kemudian kenakan bra yang memberikan dukungan. Minum obat dianjurkan jika nyerinya parah. Cari bantuan medis jika menyebabkan adalah monilia, Karena kemungkinan saluran susunya tersumbat.
- 3) Gejala: Ada luka/lecet pada puting susu, warna kemerahan dan nyeri. Pada keadaan dimana payudaranya tersumbat, payudara terasa penuh dan keras.
- 4) Penanganan: Olesi puting yang lecet dengan ASI setelah menyusui dan biarkan sampai kering.

3. Masalah Hematoma jalan lahir

Adanya hematoma, yang ditandai dengan warna ungu pada mukosa vagina atau perineum ekimosis, merupakan akibat dari kompresi ekstensif di seluruh saluran genital. Penggunaan es, analgesik, dan pemantauan terus menerus merupakan pilihan pengobatan untuk hematoma kecil. Dalam kebanyakan kasus, hematoma ini dapat diserap oleh tubuh itu sendiri. Proses mengiris dan mengeringkan hematoma yang lebih besar atau yang terus bertambah besar diperlukan untuk mencapai hemostasis. Pembuluh darah yang mengalami pendarahan diikat. Untuk mencapai hemostasis, dapat dihentikan dengan menggunakan perban vagina jika diperlukan. Insisi dan drainase dapat meningkatkan kemungkinan ibu menjadi sakit, oleh karena itu penting untuk mendapatkan obat-obatan yang efektif melawan berbagai macam infeksi. Transfusi darah diberikan jika diperlukan.

4. Inversio uteri

Kesalahan dalam pemberian dukungan pada kala III persalinan berpotensi menjadi penyebab terjadinya inversio uterus pada saat persalinan. Komplikasi umum dari inversio uterus adalah adanya syok. Meskipun perdarahan merupakan komponen yang berkontribusi terhadap terjadinya syok, syok masih dapat disebabkan oleh tarikan kuat yang dilakukan pada peritoneum, kedua ligamen infundibulo-pelvis, dan ligamen bundar meskipun tidak ada darah. Dalam kasus khusus ini, syok lebih bersifat neurogenik karena nyeri. Pembedahan sering kali dipertimbangkan dalam skenario ini, namun perlu diingat bahwa hal ini tidak menutup kemungkinan dilakukannya reposisi uterus terlebih dahulu. Namun perlu diingat bahwa hal ini tidak mengesampingkan potensi relokasi rahim sebagai langkah awal (Dhiana dkk, 2024).

5. Masalah psikologis

Ketidakmampuan merawat dirinya dan bayinya menyebabkan ibu merasa tidak bahagia.

Berikut adalah elemen yang menyebabkan masalah:

- a. Kekecewaan emosional yang sering terjadi setelah tindakan yang disertai rasa takut yang dirasakan sebagian besar wanita selama kehamilan dan persalinan.
- b. Nyeri pada awal masa postpartum.
- c. Kelelahan akibat kurang tidur selama persalinan dan seringnya melahirkan di rumah sakit
- d. Kekhawatiran bahwa dia tidak akan dapat merawat anaknya dengan baik setelah dia meninggalkan rumah sakit.
- e. Kekhawatiran bahwa ibu akan menjadi jelek setelah melahirkan.

B. Perubahan Sistem Reproduksi saat Postpartum

Setelah proses persalinan, tubuh ibu mengalami berbagai perubahan yang signifikan, terutama pada sistem reproduksi. Perubahan ini merupakan bagian dari proses pemulihan tubuh kembali ke kondisi sebelum kehamilan.

1. Perubahan pada Uterus

- a. Pengerutan Rahim (involusi)

Involusi merupakan suatu proses kembalinya uterus pada kondisi sebelum hamil. Dengan involusi uterus ini, lapisan luar dari desidua yang mengelilingi plasenta akan menjadi neurotic (layu/mati).

Perubahan ini dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan palpasi untuk meraba dimana TFUnya (tinggi fundus uteri).

- 1) Pada saat bayi lahir, fundus uteri setinggi pusat dengan berat 1000 gram
- 2) Pada akhir kala 3, TFU teraba 2 jari dibawah pusat.

- 3) Satu minggu postpartum, TFU teraba pertengahan pusat simpisis dengan berat 500 gram
- 4) 2 minggu postpartum, TFU teraba diatas simpisis dengan berat 350 gram
- 5) 6 minggu postpartum fundus uteri mengecil (tidak teraba) dengan berat 50 gram.
- 6) 8 minggu postpartum fundus uteri sebesar normal dengan berat 30 gram

Perubahan ini berhubungan erat dengan perubahan myometrium yang bersifat proteolisis.

Involusi uterus terjadi melalui 3 proses yang bersamaan, antara lain:

1) Autolysis

Autolysis merupakan proses penghancuran diri sendiri yang terjadi didalam otot uteri.

2) Atrofi jaringan

Jaringan yang berproliferasi dengan adanya ekstrogen dalam jumlah besar, kemudian mengalami atrofi sebagai reaksi terhadap penghentian produksi ekstrogen yang menyertai pelepasan plasenta. Selain perubahan atrofi pada otot uterus lapisan desidua akan mengalami atrofi dan terlepas dengan meninggalkan lapisan basal yang akan beregenerasi menjadi endometrium yang baru.

3) Efek oksitosin (kontraksi)

Intensitas kontraksi uterus meningkat secara bermakna segera setelah bayi lahir. Hal tersebut diduga terjadi sebagai respon terhadap penurunan volume intrauterine yang sangat besar. Hormon oksitosin yang dilepas dari kelenjar hypofisis memperkuat dan mengatur kontraksi uterus,

mengompresi pembuluh darah, dan membantu proses homeostatis. Kontraksi dan retraksi otot uteri akan mengurangi suplai darah ke uterus, proses ini akan membantu mengurangi bekas luka tempat implantasi plasenta dan mengurangi pendarahan. Luka bekas perlekatan plasenta memerlukan waktu 8 minggu untuk sembuh total.

b. Lokhea

Lokhea adalah ekskresi cairan rahim selama masa postpartum. Lokhea mengandung darah dan sisa jaringan desidua yang nekrotik dari dalam uterus.

Lokhea berbau amis atau anyir dengan volume yang berbeda-beda pada setiap wanita, lokhea yang berbau tidak sedap menandakan adanya infeksi.

Lokhea dibedakan menjadi 4 jenis berdasarkan warna dan waktu keluarnya:

1) Lokhea rubra/merah

Keluar pada hari pertama sampai hari keempat masa postpartum. Cairan yang keluar berwarna merah karena terisi darah segar, jaringan sisa-sisa plasenta, dinding rahim, lemak bayi, lanugo (rambut bayi), dan mekonium.

2) Lokhea sanguinolenta

Berwarna merah kecokelatan dan berlendir, serta berlangsung dari hari keempat sampai hari ketujuh postpartum.

3) Lokhea serosa

Berwarna kuning kecokelatan karena mengandung serum, leukosit, dan robekan atau laserasi plasenta. Keluar pada hari ke-7 sampai hari ke-14.

4) Lokhea alba/putih

Mengandung leukosit, sel desidua, sel epitel, selaput lendir serviks, dan serabut jaringan yang mati.

Berlangsung selama 2-6 minggu postpartum.

Lokhea yang menetap pada awal postpartum menunjukkan adanya perdarahan sekunder yang disebabkan oleh tertinggalnya sisa atau selaput plasenta. Lokhea alba atau serosa yang berlanjut dapat menandakan adanya endometritis, terutama bila disertai dengan nyeri pada abdomen dan demam. Bila terjadi infeksi, akan keluar cairan nanah berbau busuk yang disebut dengan "Lokhea purulenta". Pengeluaran Lokhea yang tidak lancar disebut dengan "Lokhea statis".

2. Laktasi

Laktasi dapat diartikan dengan pembentukan dan pengeluaran air susu ibu (ASI), yang merupakan makanan pokok terbaik bagi bayi yang bersifat alamiah. Bagi setiap ibu yang melahirkan akan tersedia makanan bagi bayinya, dan bagi si anak akan merasa puas dalam pelukan ibunya, merasa aman, tenteram, hangat akan kasih sayang ibunya. Hal ini merupakan faktor yang penting bagi perkembangan anak selanjutnya. Produksi ASI masih sangat dipengaruhi oleh faktor kejiwaan, ibu yang selalu dalam keadaan tertekan, sedih, kurang percaya diri dan berbagai ketegangan emosional akan menurunkan volume ASI bahkan tidak terjadi produksi ASI. Ibu yang sedang menyusui juga jangan terlalu banyak dibebani urusan pekerjaan rumah tangga, urusan kantor dan lainnya karena hal ini juga dapat mempengaruhi produksi ASI. Untuk memproduksi ASI yang baik harus dalam keadaan tenang.

Ada 2 refleks yang sangat dipengaruhi oleh keadaan jiwa ibu, yaitu:

a. Refleks Prolaktin

Pada waktu bayi menghisap payudara ibu, ibu menerima rangsangan neurohormonal pada putting dan areola, rangsangan ini melalui nervus vagus diteruskan ke hypophysa lalu ke lobus anterior, lobus anterior akan mengeluarkan hormon prolaktin yang masuk melalui peredaran darah sampai pada kelenjar-kelenjar pembuat ASI dan merangsang untuk memproduksi ASI.

b. Refleks *Let Down*

Refleks ini mengakibatkan memancarnya ASI keluar, isapan bayi akan merangsang putting susu dan areola yang dikirim lobus posterior melalui nervus vagus, dari glandula pituitary posterior dikeluarkan hormon oxytosin ke dalam peredaran darah yang menyebabkan adanya kontraksi otot-otot myoepitel dari saluran air susu, karena adanya kontraksi ini maka ASI akan terperas ke arah ampula.

3. Serviks

Perubahan yang terjadi pada serviks ialah bentuk serviks agak menganga seperti corong segera setelah bayi lahir, disebabkan oleh corpus uteri yang dapat mengadakan kontraksi, sedangkan serviks tidak berkontraksi sehingga seolah-olah pada perbatasan antara corpus dan serviks berbentuk semacam cincin.

Serviks berwarna merah kehitam hitaman karena penuh dengan pembuluh darah. Konsistensinya lunak, kadang-kadang terdapat laserasi atau perlukaan kecil. Karena robekan kecil yang terjadi selama berdilatasi maka serviks tidak akan pernah kembali lagi ke keadaan seperti sebelum hamil. Muara serviks yang berdilatasi sampai 10 cm sewaktu persalinan akan

menutup secara perlahan dan bertahap. Pada minggu ke-6 serviks menutup kembali.

4. Vulva dan Vagina

Vulva dan vagina mengalami penekanan, serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi. Setelah 3 minggu, vulva dan vagina kembali kepada keadaan tidak hamil dan rugae dalam vagina secara berangsur-angsur akan muncul kembali, sementara labia menjadi lebih menonjol.

Pada masa postpartum biasanya terdapat luka-luka pada jalan lahir. Luka pada vagina umumnya tidak seberapa luas dan akan sembuh secara bertahap dengan sendirinya, kecuali apabila terdapat infeksi. Infeksi mungkin menyebabkan selulitis. Yang dapat menjalar sampai terjadi sepsis.

5. Perineum

Segara setelah melahirkan, perineum menjadi kendur karena sebelumnya teregang oleh tekanan bayi yang bergerak maju. Pada postnatal hari ke-5, perineum sudah mendapatkan kembali sebagian tonusnya, sekalipun tetap lebih kendur daripada keadaan sebelum hamil.

C. Pengertian Perdarahan Postpartum

Perdarahan Postpartum (PPP) merupakan perdarahan yang terjadi karena hilangnya darah sebanyak 500 ml atau lebih dari organ-organ reproduksi setelah selesainya kala dua persalinan. Perdarahan Postpartum merupakan salah satu penyebab langsung kematian ibu dan menempati persentase tertinggi sebesar 28%. Di berbagai negara, paling sedikit seperempat dari seluruh kematian ibu disebabkan oleh perdarahan, proporsinya berkisar antara kurang dari 10-60% (WHO, 2015).

Definisi, klasifikasi, dan pengobatan perdarahan postpartum hampir tidak ada perubahan selama 50 tahun terakhir. Perdarahan postpartum ditetapkan oleh World Health Organization (2002) sebagai kehilangan darah postpartum 500 ml atau lebih yang terjadi setelah anak lahir. Perdarahan postpartum juga didefinisikan sebagai pendarahan dari saluran genital yang lebih dari 500 ml setelah melahirkan melalui vagina atau lebih dari 1000 ml setelah melahirkan secara caesarean (Alam, 2014).



Gambar 2.1 Perdarahan Postpartum

www.freepik.com

D. Penyebab Perdarahan Postpartum

Banyak faktor yang dapat menyebabkan perdarahan postpartum, diantaranya kelainan kontraksi uterus (tone) 70%, adanya sisa hasil konsepsi (tissue) 10%, trauma pada jalan lahir (trauma) 20% dan kelainan koagulasi (thrombin) <1 % (Khan, 2014).

Pada perdarahan postpartum yang disebabkan kelainan kontraksi uterus atau kontraksi tonus uteri yang berkurang, hal ini sering terjadi pada kasus atoni uteri. Uterus yang mengalami distensi mudah menjadi hipotonik sesudah kelahiran. Dengan demikian wanita dengan janin yang besar (berat janin antara

4500–5000 gram), kehamilan kembar ataupun polihidramnion cenderung mengalami perdarahan (Cunningham, 2005).

Penyebab utama perdarahan postpartum disebabkan kelainan kontraksi uteri adalah atonia uteri. Atonia uteri merupakan kegagalan miometrium untuk berkontraksi dengan baik dan mengecil sesudah janin keluar dari rahim. Pada keadaan yang normal, miometrium bisa berkontraksi sehingga memampatkan pembuluh darah yang robek dan mengontrol kehilangan darah sehingga mencegah perdarahan yang cepat dan berbahaya (Stanford, 2009).

Beberapa faktor predisposisi yang dapat mencetuskan terjadinya hipotoni dan atoni uteri meliputi umur yang terlalu muda atau tua, jumlah paritas yang sering terutama pada multipara dan grande mutipara, uterus yang teregang berlebihan, miometrium yang kelelahan seperti pada partus lama dan persalinan yang terlalu giat, pada persalinan dengan operasi, persalinan akibat induksi oksitosin, akibat anestesi umum, infeksi uterus misalnya chorioamnionitis dan endomyometritis, kelainan pada plasenta seperti pada kasus plasenta previa dan solutio plasenta, riwayat atoni uteri, dan faktor sosial ekonomi yaitu malnutrisi (Mochtar, 1998). Atoni uteri juga dapat timbul karena salah penanganan kala III persalinan, dengan memijat uterus dan mendorongnya kebawah dalam usaha melahirkan plasenta, tapi dengan teknik yang salah (Pritchard, 1991). Apabila adanya sisa hasil konsepsi seperti yang terjadi pada kasus retensio plasenta, plasenta accreta dan variasinya, perdarahan postpartum bisa terjadi. Apabila plasenta belum lahir setengah jam setelah janin lahir, hal itu dinamakan retensio plasenta. Hal ini bisa disebabkan plasenta belum lepas dari dinding uterus atau plasenta sudah lepas tetapi belum dilahirkan. Pada penemuan ultrasonografi

adanya massa uterus yang echogenik mendukung diagnosa retensio sisa plasenta dan perdarahan ini selalu berlaku beberapa jam setelah persalinan ataupun pada perdarahan postpartum sekunder. Plasenta yang belum lepas dari dinding uterus disebabkan kontraksi uterus yang kurang kuat untuk melepaskan plasenta dikenali sebagai plasenta adhesiva sedangkan plasenta yang melekat erat pada dinding uterus oleh sebab vilis komalis menembus desidua sampai miometrium sampai dibawah peritoneum diketahui sebagai plasenta akreta-perkreta. Bila plasenta sudah lepas dari dinding uterus tetapi belum keluar disebabkan oleh tidak adanya usaha untuk melahirkan atau karena salah penanganan kala III yang mengganggu kontraksi uterus sehingga terjadi lingkaran konstiksi pada bagian bawah uterus yang menghalangi keluarnya plasenta dikenali sebagai inkarserasio plasenta (Cunningham, 2005).

Terjadinya perdarahan meskipun kontraksi rahim baik dan tidak ada jaringan yang tertinggal maka trauma pada jalan lahir atau trauma genital dicurigai (Stanford, 2009). Pada trauma atau laserasi jalan lahir bisa terjadi robekan perineum, vagina, serviks, forniks dan rahim.

Keadaan ini dapat menimbulkan perdarahan yang banyak apabila tidak segera diatasi. Laserasi jalan lahir biasanya terjadi karena persalinan secara operasi termasuk seksio sesaria, episiotomi, pimpinan persalinan yang salah dalam kala uri, persalinan pervaginam dengan bayi besar, dan terminasi kehamilan dengan vacuum atau forcep dengan cara yang tidak benar. Keadaan ini juga bisa terjadi secara spontan akibat ruptur uterus, inversi uterus, perlukaan jalan lahir, dan vaginal hematoma. Laserasi pembuluh darah dibawah mukosa vagina dan vulva akan menyebabkan hematoma. Perdarahan akan tersamarkan dan

dapat menjadi berbahaya karena tidak akan terdeteksi selama beberapa jam dan bisa menyebabkan terjadinya syok. Hematoma biasanya terdapat pada daerah-daerah yang mengalami laserasi atau pada daerah jahitan perineum. Episiotomi dapat menyebabkan perdarahan yang berlebihan jika mengenai arteri atau vena yang besar, episitomi luas, ada penundaan antara episitomi dan persalinan, atau ada penundaan antara persalinan dan perbaikan episitomi (Cunningham, 2005).

Manakala pada Perdarahan Postpartum yang disebabkan kelainan pembekuan darah, gejala-gejala kelainan pembekuan darah bisa berupa penyakit keturunan ataupun didapat. Kelainan pembekuan darah bisa berupa hipofibrinogenemia, trombositopenia, thrombocytopenic purpura idiopatik, sindroma HELLP yang adanya hemolisis, enzim hati yang meningkat serta kadar trombosit yang rendah, disseminated intravaskuler coagulation (DIC), dan dilutional coagulopathy yang bisa terjadi pada transfusi darah lebih dari 8 unit karena darah donor biasanya tidak segar sehingga komponen fibrin dan trombosit sudah rusak. Perdarahan postpartum juga bisa sebagai akibat kegagalan koagulasi seperti eklampsia berat, perdarahan antepartum, cairan ketuban embolus, kematian janin intrauterine atau sepsis (Stanford, 2009).

E. Jenis-jenis Perdarahan Postpartum yang Perlu Diketahui

Menurut waktu terjadinya Perdarahan Postpartum dibagi atas:

1. Perdarahan Postpartum primer: kehilangan darah yang terjadi dalam 24 jam pertama setelah melahirkan, bisa terjadi karena atoni uteri, robekan jalan lahir, retensio plasenta, inversi uteri, ruptura uteri, dan gangguan koagulasi,



Gambar 2.2 Perdarahan primer

www.freepik.com

2. Perdarahan Postpartum sekunder: kehilangan darah yang terjadi antara 24 jam sampai 6 minggu setelah melahirkan biasanya terjadi akibat sisa plasenta dalam uteri (Prawirohardjo, 2008)



Gambar 2.3 Perdarahan sekunder

www.freepik.com

3. Perdarahan Postpartum terlambat atau sekunder: Perdarahan Postpartum sekunder biasanya terjadi antara hari ke 5 sampai hari ke 15 (Mochtar,1998).

F. Siapa yang Berisiko Mengalami Perdarahan Postpartum?

Faktor risiko perdarahan postpartum dapat ditemukan saat sebelum kehamilan, saat kehamilan, dan saat persalinan. Faktor risiko sebelum kehamilan meliputi usia, indeks massa tubuh, dan riwayat perdarahan postpartum. Faktor risiko selama kehamilan meliputi usia, indeks massa tubuh, riwayat Perdarahan Postpartum, kehamilan ganda, plasenta previa, Perdarahan Postpartum, dan penggunaan antibiotik. Sedangkan untuk faktor risiko saat persalinan meliputi plasenta previa anterior, plasenta previa mayor, peningkatan suhu tubuh $>37^{\circ}\text{C}$, korioamnionitis, dan retensio plasenta (Briley et al., 2014).

Faktor risiko utama yang mempengaruhi perdarahan postpartum menurut Sarwono (2008) adalah seperti faktor usia, gravida, paritas, jarak antara kelahiran, antenatal care, dan kadar hemoglobin. Usia aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 18-35 tahun, karena pada usia tersebut rahim sudah siap untuk menghadapi kehamilan, mentalnya sudah matang, dan sudah mampu merawat bayi dan dirinya. Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia kurang dari usia 18 dan lebih dari 35 tahun ternyata 2 sampai 5 kali lebih tinggi daripada kematian maternal yang terjadi pada usia 18-35 tahun (Sarwono, 2008). Pada ibu yang usianya kurang dari 18 tahun, secara fisik dan mentalnya belum siap untuk menghadapi kehamilan dan persalinan. Selain itu, rahim dan panggul ibu belum berkembang dengan sempurna sehingga perlu diwaspadai terhadap gangguan kehamilan. Sebaliknya pada ibu yang berusia lebih dari 35 tahun, mereka cenderung untuk mengalami komplikasi persalinan (Dep. Kes.RI, 2001).

Ibu dengan kehamilan lebih dari 1 kali mempunyai risiko lebih tinggi terhadap terjadinya perdarahan postpartum dibandingkan

dengan ibu-ibu yang termasuk golongan primigravida. Hal ini dikarenakan fungsi reproduksi mengalami penurunan pada setiap persalinan (Saifuddin, 2002). Paritas 2-3 merupakan paritas paling aman ditinjau dari sudut perdarahan postpartum yang dapat mengakibatkan kematian maternal. Paritas lebih dari atau sama dengan 4 mempunyai risiko besar untuk terjadinya perdarahan postpartum karena pada multipara otot uterus sering diregangkan sehingga dindingnya menipis dan kontraksinya menjadi lebih lemah (Pernoll, 1991).

Jarak kelahiran yang terlalu rapat (< 2 tahun) akan mengakibatkan kontraksi uterus menjadi kurang baik dan kesehatan ibu mundur secara progressive. Hal ini menyebabkan angka kejadian perdarahan postpartum lebih tinggi. Selama kehamilan berikutnya dibutuhkan 2-4 tahun agar kondisi tubuh ibu kembali seperti kondisi sebelumnya (Omrn, 1992).

Pemeriksaan antenatal yang baik dan tersedianya fasilitas rujukan bagi kasus risiko tinggi terutama perdarahan yang selalu mungkin terjadi setelah persalinan, mengakibatkan kematian maternal dapat diturunkan. Hal ini disebabkan karena dengan adanya antenatal care tanda-tanda dini perdarahan yang berlebihan dapat dideteksi dan ditanggulangi dengan cepat (Ferrer, 2001).

Akhirnya, anemia adalah suatu keadaan yang ditandai dengan penurunan nilai hemoglobin di bawah nilai normal, jika kadar hemoglobin kurang dari 8 gr%. Kekurangan hemoglobin dalam darah dapat menyebabkan komplikasi lebih serius bagi ibu baik dalam kehamilan, persalinan, dan postpartum yaitu dapat

mengakibatkan salah satunya adalah perdarahan postpartum karena atoni uteri (Cunningham, 2005).

Perdarahan postpartum juga berhubungan dengan obesitas. Risiko perdarahan akan meningkat dengan meningkatnya indeks massa tubuh. Pada wanita dengan indeks massa tubuh lebih dari 40 memiliki risiko sebesar 5,2% dengan persalinan normal (Blomberg, 2011).

BAB 3

Mengungkap Penyebab Perdarahan Pasca Melahirkan

A. Mengenal Penyebab Utama: Atonia Uteri

Perdarahan postpartum merupakan masalah serius yang dapat membahayakan nyawa ibu setelah melahirkan. Salah satu penyebab utamanya adalah kondisi yang disebut atonia uteri. Dalam kondisi ini, otot rahim (myometrium) gagal berkontraksi dengan baik setelah kelahiran bayi. Kontraksi otot rahim penting karena berfungsi menghentikan perdarahan dari tempat bekas menempelnya plasenta. Bila kontraksi ini tidak terjadi secara optimal, perdarahan dapat berlangsung terus-menerus dan dalam kasus yang ekstrem, ibu dapat meninggal dunia dalam waktu kurang dari satu jam setelah melahirkan. Atonia uteri bertanggung jawab atas lebih dari 90% perdarahan postpartum dalam 24 jam pertama setelah melahirkan.

1. Faktor predisposisi perdarahan postpartum

a. Atonia Uteri

1) Uterus membesar lebih dari normal selama kehamilan, diantaranya:

- a) Jumlah air ketuban yang berlebihan (polihidramnion).
- b) Kehamilan gemeli.

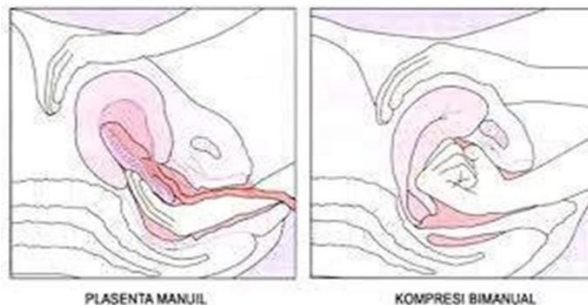
- c) Janin besar (makrosomia).
- 2) Kala satu dan/atau dua yang memanjang.
- 3) Persalinan cepat (partus presipitatus).
- 4) Persalinan yang diinduksi atau dipercepat dengan oksitosin (augmentasi).
- 5) Infeksi intrapartum.
- 6) Multiparitas tinggi.
- 7) Magnesium sulfat digunakan untuk mengendalikan kejang pada pre-eklamsia/eklamsia.
- 8) Riwayat atonia uteri / perdarahan pascapartum pada saat melahirkan anak sebelumnya.
- 9) Penanganan
 - a) Kenali dan tegakkan diagnosis kerja Atonia uteri
 - b) Sementara dilakukan pemasangan infus dan pemberian uterotonika, lakukan pengurutan uterus
 - c) Pastikan plasenta lahir lengkap (bila masih ada indikasi plasenta masih tertinggal, lakukan evakuasi sisa plasenta) dan tidak ada laserasi jalan lahir.
 - d) Berikan tranfusi darah bila sangat diperlukan.
 - e) Lakukan uji beku darah untuk konfirmasi sistem pembekuan darah.
 - f) Bila semua tindakan diatas telah dilakukan tetapi masih terjadi perdarahan lakukan tindakan spesifik sebagai berikut
 - (1) Kompresi bimanual internal

Dengan memasukkan tangan secara obstetrik kedalam vagina ibu, kepalkan tangan dalam dan tempatkan pada fornix anterior, tekan dinding anterior uterus, kearah tangan luar yang menahan dan mendorong dinding

posterior uterus ke- arah depan sehingga uterus ditekan dari arah depan dan belakang. kompresi uterus ini memberikan tekanan langsung pada pembuluh darah yang terbuka didinding uterus dan juga merangsang miometrium untuk berkontraksi.

(2) Kompresi bimanual eksternal

Kompresi uterus dengan cara saling mendekatkan tangan depan dan belakang agar pembuluh darah didalam anyaman miometrium dapat dijepit secara manual. Cara ini dapat menjepit pembuluh darah uterus dan membantu uterus untuk berkontraksi.



Gambar 3.1 Penanganan Atonia Uteri

www.freepik.com

b. Sisa placenta dan selaput ketuban

Adanya sisa placenta dan selaput ketuban yang melekat dapat menyebabkan perdarahan karena tidak dapat berkontraksi secara efektif.

Penanganannya adalah

- 1) Penemuan secara dini, hanya dimungkinkan dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan plasenta setelah dilahirkan. Pada kasus sisa plasenta dengan

perdarahan kasus pasca-persalinan lanjut, sebagian besar pasien-pasien akan kembali lagi ketempat bersalin dengan keluhan perdarahan setelah 6-10 hari pulang kerumah dan subinvolusio uterus.

- 2) Lakukan eksplorasi digital (bila servik terbuka) dan mengeluarkan bekuan darah dan jaringan bila servik hanya dapat dilalui oleh instrumen, keluarkan sisa plasenta dengan cunam ovum atau kuret besar.
- 3) Berikan antibiotic.

c. Subinvolusi

Subinvolusi terjadi jika proses kontraksi uterus tidak terjadi seperti seharusnya dan kontraksi ini lama atau berhenti. Proses involusio mungkin dihambat oleh retensi sisa plasenta atau membran janin, miomata, dan infeksi

1) Tanda dan gejala:

Dapat didiagnosa selama pemeriksaan postpartum dengan ditemukan gejala:

- a) Periode lochea lebih lama dari periode normal, diikuti dengan leukorea dan perdarahan banyak yang tidak teratur.
- b) Pemeriksaan panggul akan menunjukkan uterus lunak yang lebih besar dari ukuran normal sesuai minggu pascapartum saat rahim diperiksa.
- c) Subinvolusi awal pada masa puerperium menunjukkan uterus lunak, tidak bergerak, tidak berkurang ukurannya dan tinggi fundus tidak berubah, lochia banyak dan berwarna merah terang sampai coklat kemerahan.

2) Penatalaksanaan:

- a) Terapi dengan ergotrate atau metilergonovin (methergine), 0,2 mg per oral setiap 4 jam selama 3 hari.
- b) Evaluasi rahim dalam 2 minggu
- c) Bila terdapat tanda infeksi beri antibiotic spectrum luas.

d. Laserasi Jalan Lahir

Robekan jalan lahir merupakan penyebab kedua tersering dari per- darahan pasca partum. Robekan dapat terjadi dengan atonia uteri. Perdarahan pasca partum dengan uterus berkontraksi baik biasanya disebabkan oleh robekan servik atau vagina.

Penanganan:

- 1) Periksalah dengan seksama dan perbaiki robekan pada servik atau vagina dan perineum.
- 2) Lakukan ujian pembekuan darah sederhana jika pendarahan terus berlangsung, kegagalan terbentuknya pembentukan setelah 7 menit atau adanya bekuan lunak yang dapat pecah dengan mudah menunjukkan adanya koagulopati.

e. Kegagalan Pembekuan Darah

Koagulopati dapat menyebabkan dan akibat perdarahan yang hebat kondisi ini dapat di picu oleh solusio plasenta, kematian janin dalam uterus, eklamsia, emboli air ketuban, dan banyak penyebab lain. Gambaran klinisnya bervariasi mulai dari perdarahan hebat, dengan atau tanpa komplikasi thrombosis, sampai keadaan klinis yang stabil yang hanya terdeteksi oleh tes laboratorium.

Penanganan:

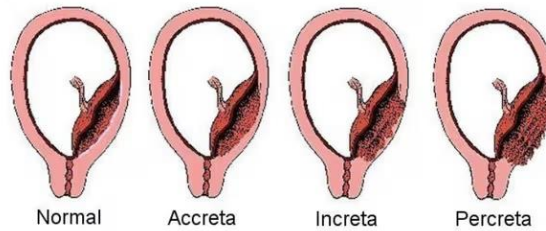
- 1) Pada banyak kasus kehilangan darah yang akut, perkembangan menuju koagulopati dapat dicegah jika volume darah dipulihkan segera dengan cairan infuse (NaCL atau Ringer Laktat).
- 2) Tangani kemungkinan penyebab kegagalan pembekuan ini
- 3) Gunakan produk darah untuk mengontrol perdarahan
 - a) Berikan darah segar, jika tersedia, untuk menggantikan Rahim pembekuan dan sel darah merah.
 - b) Jika darah lengkap segar tidak tersedia, pilih salah satu di bawah ini berdasarkan ketersediaannya:
 - (1) Plasma beku segar untuk mengganti rahim pembekuan (15ml/ kg berat badan)
 - (2) Sel darah merah packet (atau yang tersedimentasi) untuk mengganti sel darah merah.
 - (3) Kriopresipitat untuk mengganti fibrinogen
 - (4) Konsentrasi trombosit (jika perdarahan berlanjut dan trombosit di bawah 20.000)

B. Proses Terjadinya Perdarahan Postpartum

Perdarahan berasal dari tempat plasenta, bila tonus uterus tidak ada, kontraksi uterus lemah, maka arteri-arteri spiral yang seharusnya tertutup akibat kontraksi uterus tetap terbuka. Darah akan terus mengalir melalui bekas melekatnya plasenta ke cavum uteri dan seterusnya keluar pervaginam (El- Refaey, 2003).

Setelah kelahiran anak, otot-otot rahim terus berkontraksi dan plasenta mulai memisahkan diri dari dinding rahim selama jangka waktu tersebut. Jumlah darah yang hilang tergantung pada berapa cepat hal ini terjadi. Biasanya, persalinan kala III

berlangsung selama 5-15 menit. Bila lewat dari 30 menit, maka persalinan kala III dianggap lama (DepKes RI, 2004). Perdarahan postpartum bisa terjadi karena kontraksi uterus kurang kuat untuk melepaskan plasenta atau karena plasenta melekat terlalu erat pada dinding uterus (Hakimi, 2003).



Gambar 3.2 Perlekatan plasenta
www.freepik.com

C. Gejala Klinis Perdarahan Postpartum

Kehilangan darah biasanya terlihat pada pembukaan vaginal dan ini terutama berlaku setelah plasenta dikeluarkan. Salah satu presentasi biasa adalah pendarahan vagina berat yang cepat dan seterusnya menyebabkan tanda dan gejala shock hipovolemik. Namun, sejumlah darah dapat dipertahankan dalam rahim di belakang selaput plasenta jika sebagian plasenta tetap di situ (Stanford, 2009).

Selain itu, harus juga berhati-hati dengan perdarahan yang terus-menerus selama beberapa jam dan jumlahnya tampak sedang. Akhirnya, ini bisa terjadi hipovolemia yang berat dan anemia (Pritchard, 1991).

Menurut Prawiroharjo (2002) perdarahan postpartum bisa menyebabkan perubahan tanda vital seperti pasien mengeluh lemah, limbung, berkeringat dingin, menggigil, tekanan darah

sistolik <90 mmHg, nadi >100 x/menit, kadar Hb <8 gr%. Ini terutama terjadi pada pendarahan yang tidak jelas. Namun begitu, nilai tanda- tanda vital tersebut kadang-kadang bisa menyesatkan karena mempunyai bacaan yang normal (McCoy, 2010). Oleh karena itu, harus berhati-hati supaya tidak timbul hipovolemia yang berat pad pasien (Pritchard, 1991).



Gambar 3.3 Hypovolemi karena perdarahan postpartum
www.freepik.com

D. Cara Mengetahui Adanya Perdarahan Postpartum

Pada setiap perdarahan postpartum harus dicari apa penyebabnya. Untuk menentukan etiologi dari perdarahan postpartum diperlukan pemeriksaan lengkap yang meliputi anamnesis, pemeriksaan umum, pemeriksaan abdomen dan pemeriksaan dalam (Wiknjosastro, 2002).

Kadang-kadang perdarahan yang terjadi tidak keluar dari vagina, tetapi menumpuk di vagina dan di dalam uterus. Keadaan ini biasanya diketahui karena adanya kenaikan fundus uteri setelah uri keluar (Cunningham, 2005). Tinggi fundus uteri yang normal harusnya berada pada atau di bawah umbilikus. Tinggi fundus uteri dapat dikenalpastikan dengan melakukan palpasi abdomen (Alam, 2007). Pada perdarahan akibat atonia uteri terjadi

kegagalan kontraksi uterus, sehingga uterus didapatkan membesar dan lembek pada palpasi (Wiknjosastro, 2002). Sedangkan pada laserasi jalan lahir, uterus tetap berkontraksi dengan baik sehingga pada palpasi teraba uterus yang keras setelah uri keluar dengan sempurna. Darah berwarna merah kehitaman dijumpai pada kasus atoni uteri manakala darah warna merah terang akan dijumpai pada laserasi jalan lahir (Cunningham, 2005).

Pemeriksaan dalam dilakukan dengan eksplorasi vagina, uterus dan pemeriksaan inspekulo. Dengan cara ini dapat ditentukan adanya robekan dari serviks, vagina, hematoma dan adanya sisa-sisa plasenta (Wiknjosastro, 2002). Pemeriksaan laboratorium juga bisa dilakukan untuk periksa darah, Hb, clot observation test (COT) untuk mengetahui apakah adanya kelainan darah pada ibu (Mochtar,1998).

Setelah membuat diagnosis perdarahan postpartum, perlu diperhatikan adanya perdarahan yang menimbulkan hipotensi dan anemia. Apabila hal ini dibiarkan berlangsung terus, pasien akan jatuh dalam keadaan syok. Selain itu, perdarahan postpartum tidak hanya terjadi pada mereka yang mempunyai predisposisi, tetapi pada setiap persalinan. Karena itu, adalah penting sekali untuk melakukan pengukuran kadar darah secara rutin, serta pengawasan tekanan darah, nadi, pernafasan ibu dan periksa juga kontraksi uterus dan perdarahan selama 1 jam pada setiap ibu (Mochtar,1998).

E. Langkah Pencegahan yang Efektif

Tindakan pencegahan tidak saja dilakukan sewaktu bersalin, namun sudah dimulai sejak ibu hamil melakukan antenatal care yang baik. Ibu-ibu yang mempunyai predisposisi atau riwayat

perdarahan postpartum sangat dianjurkan untuk bersalin di rumah sakit (Mochtar, 1998). WHO (2007) merekomendasikan manajemen aktif kala III persalinan dengan uterotonika seperti obat ergometrin, oksitosin, dan prostaglandin yang menyebabkan rahim berkontraksi dengan lebih baik untuk mencegah dan atau menghentikan perdarahan yang berlebihan. Berikan oksitosin 10 unit secara IM setelah bayi lahir dan 0,2 unit ergometrin setelah plasenta lahir. Jangan memijat dan mendorong uterus ke bawah sebelum plasenta lepas (Mansjoer, 2001). Obat pilihan utama adalah oksitosin karena sangat efektif, memiliki profil keamanan yang sangat baik dan bebas dari efek samping yang berhubungan dengan ergometrine, AMTSL dapat mencegah sekitar 60% dari atonia uteri dan merupakan bukti intervensi berbasis biaya layak dan rendah (Stanford, 2009). Namun penggunaan oksitosin terbatas karena kurangnya profesional kesehatan untuk mengelola suntik (Tsu dan Shane, 2004).

Faktor risiko perdarahan postpartum harus diidentifikasi dan dipersiapkan sebelum hamil dilakukan (Prawirohardjo, 2008). Namun perdarahan yang signifikan mengancam nyawa dapat terjadi pada tidak adanya faktor risiko dan tanpa peringatan. Semua perawat dan fasilitas yang terlibat dalam perawatan ibu harus memiliki rencana yang jelas untuk pencegahan dan pengelolaan perdarahan postpartum.

F. Strategi Pendekatan Risiko

Kehamilan dan persalinan merupakan proses alami, tetapi bukannya tanpa risiko, yang merupakan beban bagi seorang wanita. Pada kehamilan tiap ibu hamil akan menghadapi kegawatan baik ringan atau berat yang dapat memberikan bahaya terjadinya kematian atau kesakitan bagi ibu dan atau

bayi. Sebagian besar dari kehamilan mempunyai hasil menggembirakan dengan ibu dan bayi hidup sehat. Ibu hamil dapat mengalami beberapa keluhan fisik atau mental, sebagian kecil mempunyai kesukaran selama kehamilan dan persalinan, tetapi kebanyakan ibu tersebut pulih sehat kembali sepenuhnya dengan mempunyai bayi yang normal dan sehat. Hasil yang menggembirakan tersebut tidak selalu terjadi, ada kehamilan yang berakhir dengan ibu dan atau bayi mati atau sakit. Keadaan ini dapat terjadi pada Risiko Tinggi Ibu Hamil

Pada saat ini masih banyak terjadi rujukan terlambat terutama pada kasus preeklampsia dirujuk sudah dalam keadaan eklampsia, sehingga kesempatan untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayinya sering sangat terbatas. Pendekatan pemeliharaan pada ibu hamil merupakan upaya kesehatan yang paripurna dan berkesinambungan melalui upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan (preventif), dimulai sejak awal kehamilan sampai dekat persalinan, diteruskan oleh upaya penyembuhan (kuratif) sebagai pertolongan persalinan yang memadai sesuai dengan tingkat risikonya, dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) dengan masa postpartum, laktasi/pemberian ASI dan Keluarga Berencana. Upaya pemeliharaan kesehatan ibu hamil dilakukan berbasis keluarga, sejak awal kepada suami dan keluarga perlu diberikan informasi mengenai kondisi ibu hamil.

Dalam obstetrik modern terdapat pengertian potensi risiko, dimana suatu kehamilan dan persalinan selalu dapat menyebabkan kemungkinan adanya risiko rendah maupun risiko tinggi akan terjadinya kematian.

Pendekatan risiko dimulai dengan gagasan bahwa ukuran risiko adalah gambaran adanya kebutuhan pelayanan yang lebih intensif, dimana kebutuhan ini sebetulnya sudah ada sebelum kejadian yang diramalkan itu terjadi. Pada tahun 1978 oleh WHO dikembangkan konsep „Risk Approach Strategy For Maternal Child Health Care, dengan slogan {1}: “something for all but more for those in need in proportion to that need.” Artinya “sesuatu untuk semuanya, tetapi lebih untuk yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhannya.” Pendekatan Risiko pada ibu hamil merupakan strategi operasional dalam upaya pencegahan terhadap kemungkinan kesakitan atau kematian melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi dengan memberikan pelayanan yang lebih intensif kepada risiko ibu hamil dengan cepat serta tepat, agar keadaan gawat ibu maupun bayi dapat dicegah.



Gambar 3.4 Pendekatan Risiko Pada Ibu Hamil
www.freepik.com

G. Risiko Terjadinya Perdarahan Postpartum

Risiko adalah suatu ukuran statistik dari peluang atau kemungkinan untuk terjadinya suatu keadaan gawat yang tidak diinginkan di kemudian hari, misalnya terjadinya kematian, kesakitan atau cacat pada ibu dan bayinya.

Faktor risiko adalah karakteristik atau kondisi pada seseorang atau sekelompok ibu hamil yang dapat menyebabkan peluang atau kemungkinan terjadinya kesakitan atau kematian pada ibu dan atau bayinya.

Untuk itu dibutuhkan sekali kegiatan skrining adanya faktor risiko pada semua ibu hamil sebagai komponen penting dalam perawatan kehamilan. Pengenalan adanya risiko tinggi ibu hamil dilakukan melalui skrining atau deteksi dini adanya faktor risiko secara proaktif pada semua ibu hamil, sedini mungkin pada awal kehamilan oleh petugas kesehatan atau non kesehatan yang terlatih di masyarakat, misalnya ibu-ibu PKK, Kader Karang Taruna, ibu hamil sendiri, suami atau keluarga. Kegiatan skrining antenatal, melalui kunjungan rumah merupakan langkah awal dari pemeliharaan kesehatan ibu hamil dan termasuk salah satu upaya antisipasi untuk mencegah terjadinya kematian ibu. Skrining pertama dilakukan untuk memisahkan kelompok ibu hamil tanpa risiko dari kelompok dengan faktor risiko.

Risiko terjadinya perdarahan postpartum pada ibu hamil adalah suatu ukuran statistik dari peluang atau kemungkinan untuk terjadinya suatu keadaan gawat berupa perdarahan postpartum yang tidak diinginkan dikemudian hari.

BAB 4

Mengenal Kartu Skor untuk Deteksi Dini Perdarahan Postpartum

A. Kartu Skor Deteksi Dini Risiko Perdarahan Postpartum (KSPPP)

KSPPP (KARTU SKOR PERDARAHAN PASCA PARTUM) DETEKSI DINI RISIKO PERDARAHAN PASCA PARTUM					
Nama :					
No reg :					
Dx :					
No	Tanggal pemeriksaan				
	Faktor risiko		Skor		
1	Hamil lebih dari 1 kali	1			
2	Obesitas (IMT > 30)	1			
3	Jarak kehamilan < 24 bulan	2			
4	Preeklamsi saat hamil	2			
5	Ada Riwayat PPP	3			
6	Anemia	6			
TOTAL SKOR					
KATEGORI: Risiko rendah					
Risiko tinggi					
KET: Risiko Rendah		Skor: < 5			
Risiko tinggi		Skor: ≥ 5			
REKOMENDASI/SARAN:					
Risiko rendah		: Perawatan di faskes tk I dan KIE			
Risiko tinggi		: Rujuk ke faskes tk II dan KIE			

Gambar 4.1 Kartu Skor Deteksi Dini Risiko Perdarahan Postpartum (KSPPP)

Kartu Skor Perdarahan Postpartum (KSPPP) adalah alat sederhana yang digunakan untuk melakukan deteksi dini risiko perdarahan postpartum pada ibu hamil. Kartu ini dibuat sederhana sehingga semua orang bisa menggunakannya baik itu ibu yang belum hamil maupun yang sudah hamil, kader kesehatan dan tenaga kesehatan.

Kartu Skor Perdarahan Postpartum (KSPPP) ini diharapkan mampu mendeteksi secara dini adanya risiko terjadinya perdarahan postpartum pada ibu hamil sehingga ibu hamil segera mendapatkan penanganan dan tidak sampai terjadi perdarahan postpartum, seandainya terjadi preeklampsia segera mendapatkan penanganan. Dengan demikian diharapkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dapat diturunkan.

Kartu Skor Perdarahan Postpartum (KSPPP) ini terdiri dari beberapa faktor risiko terjadinya perdarahan postpartum pada ibu yang terdiri dari hamil lebih dari 1 kali, obesitas (IMT > 30), jarak kehamilan < 24 bulan, preeklampsia saat hamil, ada Riwayat perdarahan postpartum dan anemia.



Gambar 4.2 Deteksi Dini Risiko Perdarahan Postpartum

www.freepik.com

B. Langkah Mudah Mengisi Kartu Skor KSPPP

1. Tahap pertama dari penggunaan KSDS ini adalah mengisi identitas ibu:
 - a. Nama: adalah nama lengkap ibu yang akan dihitung skor risikonya terhadap kejadian PPP.
 - b. NIK: Nomor induk kependudukan yang dimiliki oleh ibu, NIK ini kita dapatkan pada KTP atau KSK. Tujuan menuliskan NIK adalah untuk mendapatkan data akurat dari ibu, karena setiap orang mempunyai NIK yang berbeda walaupun namanya sama.
 - c. No Register: catatan nomor registrasi ibu yang melakukan pemeriksaan kehamilan pada tenaga kesehatan. Nomor register ini pasti berbeda untuk setiap ibu yang melakukan pemeriksaan kesehatan pada tenaga kesehatan yang sama.
 - d. Nakes: Adalah tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan kesehatan pada ibu hamil, data tenaga kesehatan ini penting karena untuk memudahkan melakukan penelusuran data lain yang diperlukan.
 - e. Diagnosa: diagnosa kebidanan yang meliputi riwayat kehamilan dan persalinan ini (Gravida dan Para), usia kehamilan, jumlah janin, keadaan janin, komplikasi kebidanan, komplikasi non kebidanan.
2. Tahap kedua adalah mengisi tanggal dilakukannya wawancara untuk mengisi kartu skor. Wawancara ini bisa dilakukan lebih dari satu kali, karena ada kemungkinan skornya akan berubah.

3. Tahap ketiga adalah mengisi skor pada masing-masing faktor risiko yang ada pada kartu skor dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Paritas (persalinan lebih dari 1 kali):

Kehamilan lebih dari satu kali (multigravida) adalah seseorang yang sedang hamil kedua dan seterusnya dengan kehamilan pertama lebih dari 16 minggu. Ibu yang hamil lebih dari 1 kali diberikan skor 1 dan bila hamil yang pertama diberikan skor 0.

Paritas adalah seorang wanita yang pernah melahirkan bayi yang dapat hidup (viable) (Wiknjosastro, 2006). Paritas adalah jumlah kehamilan yang menghasilkan janin yang mampu hidup di luar rahim (28 minggu) (Saifuddin, 2009). Paritas yang tinggi berisiko mengalami komplikasi selama kehamilan, persalinan dan postpartum. Setiap kehamilan rahim mengalami pembesaran, terjadi peregangan otot-otot rahim selama 9 bulan kehamilan. Akibat regangan tersebut elastisitas otot-otot rahim tidak kembali seperti sebelum hamil setelah persalinan. Semakin sering ibu hamil dan melahirkan, semakin dekat jarak kehamilan dan kelahiran, elastisitas uterus semakin terganggu, akibatnya uterus tidak berkontraksi secara sempurna dan mengakibatkan perdarahan pasca kehamilan (Saifuddin, 2009).

Selama proses kehamilan uterus akan membesar seiring dengan besarnya pelindung janin atau buah hasil konsepsi dari trauma luar uterus, menjaga kehangatan janin, menampung air ketuban. Kondisi pembesaran uterus bisa mengalami peregangan maksimal atau berlebihan yang mengarah ke kondisi patologi. Misalnya

pada kasus kehamilan kembar, polihidamnion, makrosomia, kehamilan dengan mioma atau tumor rahim. Peregangan uterus yang berlebihan pada saat kehamilan risiko terjadinya perdarahan postpartum. Hal ini karena kontraksi uterus yang kurang maksimal sehingga pembuluh darah yang terbuka akibat luka persalinan tidak terjepit secara maksimal.

b. Obesitas:

Obesitas adalah seseorang yang mempunyai indeks massa tubuh (IMT) lebih dari 30. Bila ibu hamil mempunyai $IMT > 30$ diberikan skor 1 dan bila $IMT < 30$ diberikan skor 0.

Obesitas dapat diartikan sebagai akumulasi lemak abnormal pada tubuh seseorang yang terjadi karena asupan energi yang melebihi pengeluaran kalori. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh faktor genetik, metabolisme endokrin, faktor psikologis dan budaya. Obesitas disamping dapat menyebabkan kolesterol tinggi dalam darah juga dapat menyebabkan kerja jantung lebih berat, sehingga jumlah darah yang berada dalam badan hanya sekitar 15% dari berat badan. Semakin gemuk seseorang makin banyak pula jumlah darah yang berada di dalam tubuhnya, yang berarti semakin berat kerja jantung dalam memompa. Hal ini dapat menambah risiko terjadinya perdarahan postpartum (Suhardiyanto, 2012).

Penambahan berat badan mempengaruhi penyebab kejadian PPP pada ibu bersalin, wanita dengan indeks massa tubuh yang lebih besar dari 30 pada awal kehamilan cenderung berisiko mengalami perdarahan

postpartum. Perkiraan peningkatan risiko PPP sebelum kehamilan menurut Robson adalah 2,5 kali lipat, sedangkan pada saat pemeriksaan antenatal meningkat 1,5 kali lipat. Kenaikan berat badan yang terjadi pada ibu hamil berkaitan dengan puncak respon radang yang berhubungan dengan IMT yang tinggi dan kenaikan kadar lipid darah yang berhubungan dengan obesitas.

Berdasarkan dari data hasil wawancara yang telah dilakukan dan catatan dari antenatal care, ibu yang mengalami obesitas sebagian besar sudah memiliki berat badan yang berlebih sebelum hamil. Kelebihan berat badan tersebut, dikarenakan kebiasaan mengkonsumsi makanan yang berlebih dan makan makanan ringan. Kebiasaan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat seperti makanan siap saji seperti mie, nugget, dan sozzis, ibu lebih sering beli makanan jika dibandingkan dengan masak sendiri di rumah. Makanan yang di jual bebas banyak mengandung bahan-bahan yang tidak aman buat kesehatan, baik itu pewarna, pengawet, pemutih dan pemanis buatan. Kebiasaan ini dikarenakan pasien mengalami mual, muntah, penurunan kondisi tubuh dan ketidakmampuan memakan makanan tertentu pada trimester pertama. Saat mendekati trimester ke tiga, ibu secara berlebihan mengkonsumsi makanan berlemak dan rendah serat.

c. Jarak kehamilan (kurang dari 24 bulan):

Jarak kehamilan kurang dari 24 bulan adalah seseorang yang sedang hamil kedua dan seterusnya dan memiliki jarak dengan persalinan sebelumnya kurang dari 24 bulan. Ibu yang hamil dengan jarak kehamilan kurang dari

24 bulan diberikan skor 2 dan bila jarak kehamilan lebih dari 24 bulan diberikan skor 0.

Interval kehamilan kurang dari 24 bulan (2 tahun) berisiko secara bermakna terhadap kejadian perdarahan postpartum. Pada Interval kehamilan terlalu pendek (<2 tahun) uterus belum cukup waktu untuk kembali pulih secara fisiologis dari tekanan kehamilan sebelumnya. Kondisi uterus pada jarak kehamilan pendek belum mampu secara maksimal untuk memberikan cadangan nutrisi bagi ibu dan janin, sehingga ibu mengalami gangguan gizi dan anemia serta gangguan perkembangan janin. Pada interval kehamilan terlalu jauh berkaitan dengan umur maternal yang semakin bertambah, dengan bertambahnya usia maka saat persalinan kekuatan fungsi otot-otot uterus dan otot panggul melemah. Interval kehamilan jauh pengaruhnya hampir sama seperti pada persalinan primipara. 31 Baik interval kehamilan pendek atau interval lama pada dasarnya berpengaruh terhadap morbiditas maternal terkait dengan berbagai komplikasi yang ditimbulkan.

d. Preeklampsia saat hamil:

Preeklamsia saat hamil adalah seorang ibu yang sedang hamil dan mengalami preeklampsia dengan ditandai ada peningkatan tekanan darah (lebih dari 130/90 mmHg), adanya protein dalam urine dan bengkak (edema). Ibu yang hamil dengan preeklamsia diberikan skor 2 dan tidak ada preeklampsia diberikan diberikan skor 0.

Terjadinya preeklampsia mungkin didasarkan pada gen resesif tunggal atau gen dominan dengan penetrasi yang

tidak sempurna. Penetrasi mungkin tergantung genotip janin (Haryono R, 2006). Menurut Mochtar (2002) preeklamsia pada kehamilan merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya PPP. Perempuan mempunyai risiko lebih besar mengalami PPP bila saat hamil mengalami preeklamsi atau yang telah mengidap hipertensi kurang lebih 4 tahun (Cunningham, 2006).

e. Ada Riwayat perdarahan postpartum:

Ada riwayat perdarahan postpartum adalah apabila ibu yang sedang hamil pernah mengalami perdarahan pada persalinannya yang lalu. Ibu yang mengalami perdarahan pada persalinannya yang lalu diberikan skor 3 dan bila tidak pernah mengalami perdarahan pada persalinan yang lalu diberikan skor 0.

Bagian dari otak yang mengontrol mekanisme konstiksi dan relaksasi adalah medulla, disebut dengan pusat vasomotor. Dari pusat vasomotor ini, bermula jaras saraf simpatis, yang berlanjut ke bawah ke korda spinalis dan keluar dari kolumna medulla spinalis ganglia simpatis di toraks dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui sistem saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada titik ini, neuron preganglion melepaskan asetilkolin, yang akan merangsang serabut saraf pasca ganglion ke pembuluh darah, dimana dengan dilepaskannya norepineprin mengakibatkan konstiksi pembuluh darah (Brunner & Suddarth, 2002).

Komplikasi yang terjadi pada ibu bersalin dipengaruhi oleh status kesehatan sebelum masa kehamilan maupun

pada saat kehamilan. Dengan demikian, setiap wanita harus dapat menjaga kesehatan reproduksinya di sepanjang daur kehidupan karena akan berpengaruh terhadap kondisi ketika hamil dan melahirkan.

f. Anemia (Hb kurang dari 10 mg%)

Anemia adalah suatu keadaan dimana ibu hamil mempunyai jumlah sel darah merah yang rendah (hasil pemeriksaan Hb < 10 mg%. Ibu hamil yang anemia diberikan skor 6 dan bila tidak anemia diberikan skor 0

Anemia dalam kehamilan disebut sebagai "Potential Danger to Mother and Child, Anemia dalam kehamilan disebabkan oleh keperluan akan zat-zat makanan bertambah dan terjadi pula penambahan dalam darah dan sumsum tulang. Darah bertambah banyak dalam kehamilan yang lazim disebut hidremia atau hipovolemia. Akan tetapi bertambahnya sel-sel darah kurang dibanding dengan bertambahnya plasma sehingga terjadi pengenceran darah. Pertambahan tersebut berbanding yaitu plasma 30 %, sel darah 18 % dan hemoglobin 19%. Di dalam tubuh banyaknya sel darah merah ini bisa kurang, demikian juga banyaknya hemoglobin dalam sel darah merah, apabila keduanya berkurang maka keadaan ini disebut anemia.

Anemia pada kehamilan paling banyak disebabkan oleh kurangnya masukan unsur besi dalam makanan karena gangguan reabsorpsi, gangguan penggunaan atau karena terlampaui banyaknya besi keluar dari tubuh misalnya karena perdarahan. Anemia postpartum menyebabkan perlakuan sukar sembuh sehingga terjadi

perdarahan (Manuaba, 2007: 50- 51). Anemia pada kala uri menyebabkan retensio plasenta, pada postpartum menyebabkan atonia uteri dan sub involusi uteri sehingga timbul perdarahan postpartum (Manuaba, 2007: 30- 37). Bahaya pada postpartum jika terdapat anemia makan akan memperlemah keadaan menurunkan daya tahan tubuhnya dan menjadi faktor predisposisi terjadinya infeksi postpartum, jika kehilangan darah ini tidak berhenti akibat akhirnya adalah kematian (Hakimi, 2007: 413).

Anemia pada saat kehamilan akan berpengaruh terhadap persalinan dan paska persalinan (kala postpartum). Bahaya anemia selama persalinan dapat menimbulkan gangguan his, kala satu dan kala dua berlangsung lama sehingga dapat melelahkan dan sering memerlukan tindakan operasi kebidanan, gangguan kala uri yang dapat diikuti retensio plasenta, dan perdarahan postpartum karena atonia uteri, kala empat dapat terjadi perdarahan postpartum sekunder dan atonia uteri. Oleh karena itu dalam upaya mencegah anemia pada ibu hamil suplemen tablet Fe pada ibu hamil tetap perlu diberikan melihat kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih miskin terutama daerah pedesaan.



Gambar 4.3 Pemeriksaan Kehamilan
www.freepik.com

C. Menentukan Tingkat Risiko dengan Cepat

Kategori dalam kartu skor ini dibagi menjadi 2 yaitu kategori risiko rendah terjadi perdarahan postpartum dan kategori risiko tinggi terjadi PPP. Menentukan kategori risiko rendah terjadi PPP atau kategori risiko tinggi terjadi preeklampsia adalah dengan menghitung total skor yang diperoleh. Bila total skor yang diperoleh kurang dari 5 maka ibu tersebut risiko rendah mengalami PPP, sementara bila total skornya lebih besar atau sama dengan 5 maka ibu tersebut risiko tinggi mengalami perdarahan postpartum.

D. Mengartikan Hasil Kartu Skor KSPPP

Hasil klasifikasi deteksi dini risiko perdarahan postpartum didapatkan dua kategori. Setiap kategori diberikan rekomendasi untuk perawatan selanjutnya sehingga penderita yang berisiko perdarahan postpartum akan mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kategori risikonya. Adapun rekomendasi untuk setiap kategori adalah sebagai berikut:

1. Risiko rendah : dilakukan perawatan di fasilitas kesehatan tingkat satu dan diberikan KIE.

2. Risiko tinggi : harus dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat dua dan diberikan KIE. Lebih dulu dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat satu untuk persiapan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat dua.

BAB 5

Mudah dan Cepat: Aplikasi Digital KSPPP

A. Mengenal Aplikasi Digital Deteksi Risiko Perdarahan

Kartu Skor Deteksi Dini Risiko Perdarahan Postpartum (KSPPP) adalah kartu deteksi dini terjadinya risiko perdarahan postpartum pada ibu hamil yang dapat digunakan oleh masyarakat/kader dan tenaga kesehatan. Diharapkan dengan menggunakan KSPPP ini ibu hamil dapat segera terdeteksi bila ada risiko mengalami perdarahan postpartum dan segera mendapatkan perawatan sehingga tidak mengalami perdarahan postpartum dan angka kematian ibu dapat diturunkan.

KSPPP dapat digunakan oleh semua lapisan mulai dari ibu hamil, kader, bidan, perawat dan dokter. Untuk memudahkan penggunaan KSPPP ini selain menggunakan dalam bentuk Kartu Skor juga dibuat dalam bentuk aplikasi berbasis android yang dapat diunduh di play store.

Dengan aplikasi ini diharapkan semua orang bisa melakukan deteksi dini risiko terjadinya perdarahan postpartum sehingga semua ibu yang terdeteksi berisiko mengalami perdarahan postpartum dapat segera dirujuk dan mendapatkan perawatan.

Aplikasi KSPPP sangat mudah pengoperasiannya, berikut adalah cara pengoperasian dan tampilan yang bisa dilihat pada aplikasi KSPPP:

B. Panduan Penggunaan Aplikasi KSPPP secara Praktis

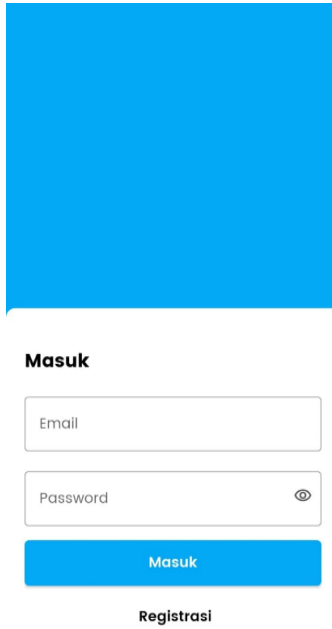
1. Bagian Depan

Bagian ini adalah yang tampil ketika kita sudah mengunduh aplikasi di KSPPP pada handphone berbasis android.



Gambar 5.1 Tampilan depan aplikasi KSPPP

2. Akun



Masuk

Email

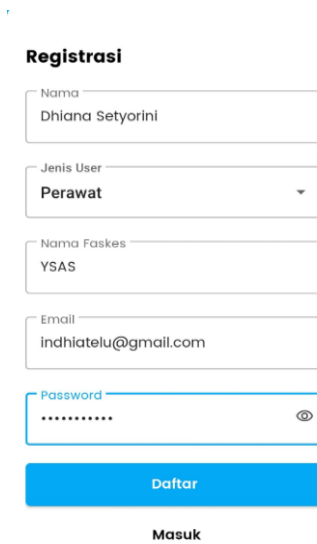
Password

Masuk

Registrasi

Gambar 5.2 Membuat akun

3. Pendaftaran akun/registrasi



Registrasi

Nama
Dhiana Setyorini

Jenis User
Perawat

Nama Faskes
YSAS

Email
indhiatelu@gmail.com

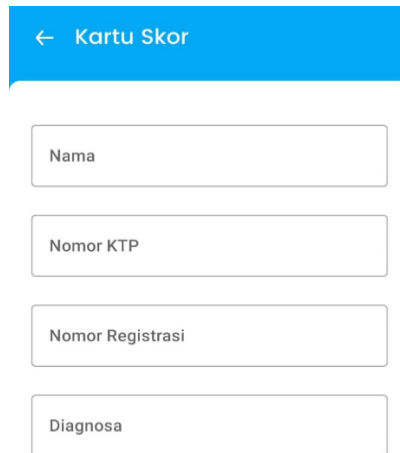
Password

Daftar

Masuk

Gambar 5.3 Registrasi

4. Beranda terdiri dari:
- Data dasar ibu hamil yang terdiri dari: Nama, nomor KTP dan nomor registrasi.



← Kartu Skor

Nama

Nomor KTP

Nomor Registrasi

Diagnosa

Gambar 5.4 Data Dasar Ibu

- Faktor risiko yang berisi tentang faktor risiko terjadinya perdarahan postpartum pada ibu hamil dilengkapi dengan skor yang akan menentukan berapa skor ibu hamil terhadap risiko terjadinya perdarahan postpartum.
-
- Pada bagian bawah akan ditampilkan: Hasil penghitungan skor, kategori berisiko dan tidak berisiko serta rekomendasi dari hasil kategori.

Faktor Risiko

☐ Hamil lebih dari 1 kali

☒ Obesitas (IMT >30)

☐ Jarak kehamilan kurang dari 24 bulan

☐ Preeklamsi saat hamil

☐ Ada Riwayat PPP

☒ Anemia

Kirim

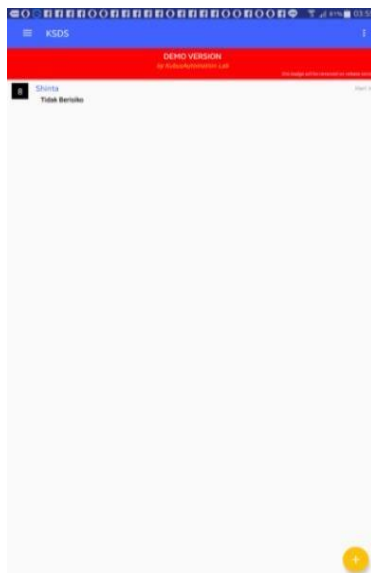
Risiko Tinggi Skor

Rujuk ke faskes tk II dan KIE **7**

Gambar 5.5 Penentuan Faktor Risiko, Skor dan rekomendasi

e. Selanjutnya:

- 1) Klik Simpan.
- 2) Data yang telah disimpan akan ditampilkan dalam format sebagai berikut:



Gambar 5.6 Data Ibu Hamil

- f. Melihat data yang tersimpan
- 1) Klik pada data ibu hamil tersebut.
 - 2) Tampilan berikutnya adalah akan terlihat faktor risiko apa saja yang ada pada ibu hamil tersebut.

The screenshot shows a mobile application interface with a green header and a white content area. The header has a back arrow and the word 'Detail'. The content area is divided into two sections: 'Data Dasar' and 'Faktor Risiko'. The 'Data Dasar' section contains the following information: 'Nama Ibu: Shinta', 'Nomor KTP: 3525154310960005', and 'Nomor Registrasi: 002'. The 'Faktor Risiko' section contains the following information: 'PENGHASILAN < UMR (Rp. 3.042.000)' with a value of '1', 'Hamil lebih dari 1 kali' with a value of '1', and 'Gemuk (BMI > 25)' with a value of '6'. At the bottom of the screen, there is a green bar with the text 'Tidak Berisiko' and a small icon, and a black bar with the text 'Perawatan di FASKES H. I dan KIA' and a large number '8'.

Data Dasar	
Nama Ibu:	Shinta
Nomor KTP:	3525154310960005
Nomor Registrasi:	002

Faktor Risiko	
PENGHASILAN < UMR (Rp. 3.042.000)	1
Hamil lebih dari 1 kali	1
Gemuk (BMI > 25)	6

Tidak Berisiko

Perawatan di FASKES H. I dan KIA

8

Gambar 5.7 Data Dasar Ibu Hamil dan Faktor Risiko Yang Ada Pada Ibu

- g. Mengirim data.
- 1) Data yang sudah tersimpan dapat dikirimkan melalui semua media yang ada di android. Cara mengirim data dengan meng-klik pilihan *export* data pada pilihan diatas data ibu yang sudah tersimpan.



Gambar 5.8 Cara Mengirim Data

- 2) Pilih export untuk mengirim data, akan ditampilkan berbagai media untuk mengirim data, pilih email maka data akan terkirim ke email: indhiatelu@gmail.com
- 3) Data yang sudah terkirim ke email dalam bentuk excel.

A	B	C	D	E	F	G
1	ID	Tanggal	Bumi	KTP	NoReg	Skor
2	1	2017-09-21	Bumi	351111111111	0001	1
3	2	2017-09-22	Eku	0708038003	0002	1
4	3	2017-09-22	Ksa	0132	222	1

Gambar 5.9 Data ibu hamil yang terkirim di email indhiatelu@gmail.com

BAB 6

Mengelola Perdarahan dengan Sistem Rujukan yang Efektif

A. Pengertian Sistem Rujukan dalam Penanganan Perdarahan

Sistem rujukan merupakan suatu susunan dimana berbagai komponen jaringan pelayanan kesehatan ibu dapat berinteraksi untuk mencapai rasionalisasi penggunaan sumber daya kesehatan ibu secara relevan, efisien, efektif dan rasional. Sistem rujukan adalah suatu jaringan pelayanan yang memungkinkan penyerahan tanggung secara timbal balik atas masalah yang timbul secara vertikal maupun horizontal kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu untuk memberikan penanganan adekuat.

Dalam Sistem rujukan, sarana/prasarana alat yang berteknologi canggih dan spesialis dipusatkan pada suatu tempat, yaitu rumah sakit kabupaten atau rumah sakit propinsi (fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 2).

Penggunaan kartu skor “Perdarahan Pasca Partum” ini diharapkan ibu hamil dapat secara dini terdeteksi adanya risiko terjadi perdarahan pasca partum saat melahirkan dan postpartum. Sehingga bisa segera dilakukan rujukan terencana baik ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat satu maupun tingkat dua.

Rujukan terencana merupakan suatu model rujukan dikembangkan secara sederhana, mudah dimengerti, dapat disiapkan/direncanakan oleh ibu hamil, suami, keluarga dan masyarakat dengan santai dan gotong royong, kemudian berakhir ibu dan bayi hidup sehat. Rujukan terencana ini merupakan salah satu upaya untuk melakukan pencegahan terhadap empat terlambat, yaitu terlambat dalam: pengenalan masalah, pengambilan keputusan dalam keluarga, pengiriman ke pusat rujukan dan penanganan adekuat di Rumah Sakit.

B. Langkah Pencegahan Sebelum Merujuk

1. Pengenalan masalah/faktor risiko:

Masalah/faktor risiko terjadinya perdarahan postpartum pada ibu hamil didapatkan dan ditemukan melalui deteksi dini dan pro aktif pada setiap ibu hamil pada awal kehamilan (trimester I) bahkan bisa dilakukan sebelum hamil dengan KSPPP. Pada ibu yang berisiko terjadi preeklampsia harus dilakukan rujukan dan diberikan penyuluhan kesehatan (KIE) tentang bahaya/komplikasi dengan risikonya kepada ibu hamil, suami dan keluarganya.

2. Pengambilan keputusan dalam keluarga:

Setelah berulang kali diberikan penyuluhan kesehatan oleh tenaga kesehatan, maka keluarga akan berkembang perilaku peduli dan waspada mengenai adanya masalah. Kemudian diikuti dengan persiapan dan perencanaan tempat perawatan

kehamilan. Akhirnya ada kesiapan mental, biaya dan transportasi.

3. Pengiriman dan transportasi:

Segera dilakukan rujukan agar dapat perawatan yang lebih baik dan perdarahan postpartum bisa dicegah atau mendapat terapi yang sesuai. Ibu dan janin dalam keadaan sehat.

4. Penanganan adekuat profesional:

Penilaian dan pertimbangan klinis segera dilakukan dokter SpOG untuk menentukan terapi yang sesuai dengan keadaan ibu dengan pemanfaatan alat dan obat secara relevan, rasional, efisien dan biaya terkendali.

C. Mengenal Rujukan Terencana

Rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi (tingkat 1 atau 2) oleh tenaga kesehatan bersama ibu hamil, suami atau keluarga yang dapat disiapkan dan direncanakan jauh hari sebelum persalinan dan merupakan suatu pendekatan pencegahan proaktif berbasis keluarga.

Telah dikembangkan suatu model rujukan terencana, yaitu:

1. Rujukan Dini Berencana: rujukan yang dilakukan pada ibu hamil dengan kategori berisiko dari hasil pengkajian dengan KSPPP.
2. Rujukan Tepat Waktu: rujukan harus segera dilakukan dalam upaya penyelamatan ibu dan janin. Rujukan ini terutama dilakukan pada ibu dan janin yang berada dalam keadaan gawat.

D. Manfaat Sistem Rujukan Terencana bagi Ibu dan Bayi

1. Ada kemudahan untuk pergi berangkat ke tempat rujukan, ibu dapat berjalan sendiri tanpa kesakitan, tidak membutuhkan alat dan obat.

2. Transportasi menggunakan kendaraan umum, ibu duduk santai dengan biaya murah.
3. Ibu dengan risiko PPP dalam kondisi baik sebelum tindakan dan tidak butuh stabilisasi.
4. KIE bisa dilakukan dengan santai kepada ibu hamil dan keluarganya.
5. Tindakan dapat direncanakan waktunya.
6. Alat, obat dan prosedur standar dapat menggunakan obat generik, dengan biaya yang jauh lebih murah.
7. Hasil perawatan dengan ibu dan bayi sehat.

BAB 7

Langkah Selanjutnya untuk Masa Depan Lebih Aman

Setiap wanita dan setiap pasangan pasti menginginkan adanya kehamilan, namun setiap kehamilan pasti mempunyai risiko. Salah satu risiko yang akan dihadapi ibu hamil adalah terjadinya perdarahan post partum atau disingkat PPP. Deteksi dini risiko terjadinya PPP harus dilakukan pada semua ibu hamil supaya dapat diketahui sedini mungkin risiko terjadinya PPP pada semua ibu hamil.

Kartu Skor Perdarahan Post Partum (KSPPP) dapat digunakan oleh kader, bidan, perawat dan dokter untuk mendeteksi secara dini adanya risiko PPP pada ibu hamil. Diharapkan dengan menggunakan KSPPP ini ibu dapat segera terdeteksi secara dini kemungkinan adanya risiko terjadinya perdarahan postpartum sehingga ibu segera mendapatkan perawatan. Kader dan masyarakat perlu mendapatkan pelatihan tentang deteksi dini risiko PPP dan tanda risiko kehamilan lainnya sehingga mampu memberikan penyuluhan kesehatan kepada ibu. Ibu hamil yang mendapatkan penyuluhan tentang risiko kehamilan akan mau dan mampu dilakukan rujukan bila didapatkan risiko terjadinya perdarahan post partum.

Rujukan yang dilakukan pada ibu yang terdeteksi dini adanya risiko perdarahan postpartum adalah rujukan terencana sehingga bisa dicegah terjadinya kematian dan kecacatan pada ibu dan janin, hasil akhir yang diharapkan adalah angka kematian ibu dan bayi dapat diturunkan.

Daftar Pustaka

- Alam, (2015). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Perdarahan Postpartum Di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang Tahun 2007*, [http://journalstikesmp.ac.id/filebae/manuskrip%20murbiah%20edit%20\(3\).pdf](http://journalstikesmp.ac.id/filebae/manuskrip%20murbiah%20edit%20(3).pdf) Volume 3, Edisi 2, Desember 2015
- Asif Y, (2016). *Beberapa Faktor Kejadian Perdarahan Postpartum Ibu Bersalin Yang Dirawat Di Rumah Sakit*, Tesis Pasca Sarjana Prodi Magister Epidemiologi UNDIP Semarang
- Erawati, (2014). *Analisis determinan perdarahan postpartum di rumah sakit*, *Jurnal Keperawatan*, Volume X, No. 2, Oktober 2014
- Besty, (2015). *Faktor - Faktor Terjadinya Perdarahan Postpartum Di Ruang Ponak RSUD Jombang*, [http://journalstikejbg.ac.id/filebae/manuskrip%20besty%20edit%20\(3\).pdf](http://journalstikejbg.ac.id/filebae/manuskrip%20besty%20edit%20(3).pdf) Volume 3, Edisi 2, agustus 2015
- Blomberg, (2011). *A tekbook and reference Book for Midwiferyin Southern Africa*, Volume II Complicationin Childbirth
- Briley *et al*, (2014). *SDGs dan Kematian ibu di Indonesia pasca MDGs*
- Cunningham, F., Gary., Norman, F., Gant., Kenneth, J., Leveno., Larry, C., Gilstrap., John, C., Hauth Katharine, D., Wenstrom. (2013). *Obstetri Williams*, Jakarta: EGC, hal 241-435
- Dhiana Setyorini, Retno Dewi Priskusanti, Atik Badi'ah dkk (2024), *Keperawatan Maternitas (Teori dan Aplikasi)*, Media Sains Indonesia, Jakarta
- Hakimi, (2015). *Pencapaian MDGs dan Analisa Kematian Ibadan Balita di Indonesia; Seminar Capaian target MDGs 2015, Pelayanan Kesehatan Primer dan Sistem Rujukan, Pendidikan Kesehatan/Kedokteran di Era Jaminan Kesehatan Nasional*. Semarang, 28 Maret 2015.
- Khan, (2014). *Postpartum haemorrhage management, risks, and maternal outcomes: findings from the World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health*, BJOG 2014;

121 (Suppl. 1): 5–13.

Kemenkes RI, 2011 *Depkes*, R.I. (2013). *Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta:

<http://www.depkes.go.id/downloads/publikasi/Profil%20Kesehatan%20Indonesia%202012.pdf>

Mansjoer, (2011). *Sinopsis Obstetri; Obstetri Operatif, Obstetri Sosial: Penulis* Sofian A. Edisi 3, Jilid 2, Jakarta: EGC.

Marlina, (2011), *Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian Haemoragic Postpartum di Rumah Bersalin Wijaya Kusuma Tahun 2014*, Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat, Vol.10, No.1, Maret 2016, pp. 21~ 28, ISSN: 1978 - 0575

Martaadisubrata, (2011). *Bunga Rampai Obstetri Gynecologi Sosial*. Jakarta:Yayasan Bina Pustaka

McCoy, (2016). *Prevention and Treatment of Postpartum Hemorrhage in Low-Resource Settings. Reproduced with permission granted by FIGO, from Lalonde A. Prevention and treatment of postpartum hemorrhage in low-resource settings. Int J Gynaecol Obstet* 2012;117: 108–118.

Omrn, (2014). *Obstetric Risk Factors and Outcome of Pregnancies Complicated with Early Postpartum Hemorrhage: A Population-based Study. The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine*, September 2005; 18(3): 149–154

Putri, (2014). *Beberapa Faktor Kejadian Perdarahan Postpartum Ibu Bersalin Yang Dirawat Di Rumah Sakit, Keperawatan, Volume XII, No. 2, Oktober 2016*

Prawirohardjo, Sarwono. (2014), *Ilmu Kebidanan*. Jakarta:Yayasan Bina Pustaka

Poedji Rochjati, (2003). *Pelayanan Kebidanan di Indonesia; Ilmu Kebidanan Sarwono Prawiroharjo*. Editor Saifudin AB, Rachimhadhi T, Wiknjosastro G. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo; 2009: 35-52 Saifuddin, 2002, *Ilmu Kebidanan*. Jakarta:Yayasan Bina Pustaka

Sugi P, (2014). *Determinan Faktor Penyebab Kejadian Perdarahan Postpartum Karena Atonia Uteri, Jurnal Ilmiah Universitas*

Sulin, Djusar, (2010). *Ilmu Kebidanan Edisi 4*. Jakarta: Bina Pustaka

Tsu dan Shane, 2014, , [https://cits16.wordpress.com/2016/07/04/sdgs-dan-kematian-ibu-di-indonesia/diakses 25 Juli 2017](https://cits16.wordpress.com/2016/07/04/sdgs-dan-kematian-ibu-di-indonesia/diakses%2025%20Juli%202017), 16.15

WHO (2010), *Dibalik angka pengkajian kematian maternal dan komplikasi untuk mendapatkan kehamilan yang lebih aman.*
<http://www.who.int/reproductive-health/publication/rh-indikator>
diakses tgl 13 Januari 2014

Glosarium

A

Anamnesa: Proses pengumpulan informasi mengenai riwayat kesehatan pasien melalui wawancara dengan pasien atau keluarga pasien. Dalam konteks medis, anamnesa dilakukan untuk memahami keluhan, gejala, riwayat penyakit, dan faktor risiko yang dapat membantu dalam proses diagnosis dan perencanaan pengobatan.

Android: Sistem operasi perangkat mobile

Antenatal Care: Perawatan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil selama masa kehamilan

B

BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah): Kondisi ketika bayi yang baru lahir memiliki berat badan yang lebih rendah dari normal, yaitu kurang dari 2.500 gram, terlepas dari usia kehamilannya.

D

Diagnosis: proses identifikasi penyakit atau kondisi medis berdasarkan gejala, tanda-tanda klinis, hasil pemeriksaan fisik, serta hasil laboratorium dan diagnostik lainnya.

E

Eklampsia: Kondisi medis yang berbahaya selama kehamilan yang ditandai dengan kejang-kejang yang terjadi setelah preeklampsia, yaitu kondisi hipertensi (tekanan darah tinggi) yang disertai dengan adanya protein dalam urine.

H

Hipertensi: peningkatan tekan darah lebih dari 140/90 mmHg

Hematoma: Perdarahan yang mengumpul dibawah kulit.

I

Involusi: Proses kembalinya alat reproduksi seperti keadaan sebelum hamil

L

Lochea: keluaran melalui jalan lahir/vagina pada masa nifas yang terdiri dari darah segar bercampur sisa- sisa selaput ketuban, verniks kaseosa, rambut lanugo, sel- sel desidua, dan mekoneum.

M

Mastitis: Peradangan yang terjadi pada payudara selama fase menyusui

N

Nifas: masa setelah melahirkan sampai dengan 40 hari

P

Partus/persalinan: Proses pengeluaran hasil kehamilan mulai dari pembukaan jalan lahir sampai lahirnya plasenta

Profil Penulis



Dr. Ns. Dhiana Setyorini, M.Kep., Sp.Mat

Dosen di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Riwayat pendidikan setelah lulus SMA adalah Akper Sutomo Surabaya lulus tahun 1991 kemudian lanjut Profesi Ners PSIK Fakultas Kedokteran Unair lulus tahun 2002. S2 Keperawatan dan Spesilis Keperawatan Maternitas beliau selesaikan tahun 2007

di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIKUI) kemudian penulis melanjutkan kuliah Program Doktorat (S3) Ilmu Kesehatan Di FKM Unair lulus tahun 2017. Penulis aktif sebagai pembicara seminar dan fasilitator pelatihan gawat darurat maternal neonatal. Selain itu penulis juga aktif melakukan kegiatan penelitian dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Beberapa buku sudah dihasilkan oleh penulis diantaranya Manajemen preeklampsia dan Eklampsia, KIA, Asuhan Keperawatan Maternitas, Deteksi Dini Risiko Preeklamsia Dan Eklampsia, Deteksi Dini Risiko Perdarahan Postpartum, Modul Pelatihan Basic Trauma Cardio Maternal Neonatal Manajemen, Modul Manajemen Keperawatan, Modul Etika Keperawatan, Kebutuhan dasar manusia, manajemen keperawatan, metode penelitian, keperawatan profesional dan banyak buku lainnya.

Penulis aktif dalam organisasi profesi Ikatan Perawat Maternitas Indonesia baik di tingkat pusat maupun Wilayah Jawa Timur, tahun 2010-2017 menjadi ketua Ikatan Perawat Maternitas Indonesia Wilayah Jawa Timur selama 2 priode dan sekarang menjadi pengurus di Tingkat Pusat dan Tingkat Wilayah.

Email: indhia.telu@gmail.com

Profil Penulis



INTIM CAHYONO, S.Kep., Ns., M.Kes

Dosen di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Riwayat pendidikan setelah lulus SMA adalah Akper Karya Husada Kediri Surabaya lulus tahun 1990 kemudian lanjut Profesi Ners PSIK Fakultas Kedokteran Unair lulus tahun 2002. S2 Kesehatan Masyarakat beliau selesaikan tahun 2009 di Fakultas Kesehatan

Masyarakat Universitas Airlangga, penulis aktif mengajar di mata kuliah Keperawatan Jiwa. Selain itu penulis juga aktif melakukan kegiatan penelitian dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Penulis aktif dalam kegiatan menulis buku diantara buku Deteksi Dini risiko Preeklamsi, buku Deteksi Dini Risiko Perdarahan Postpartum, Kebutuhan Dasar Manusia, Falsafah dan Teori Keperawatan, Manajemen Keperawatan, Buku Ajar Keperawatan Jiwa dan beberapa buku yang lain .

Email: intimselalu@gmail.com



NUR HASANAH, SKM., M.Kes

Dosen di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surabaya sejak tahun 2001 hingga saat ini. Penulis aktif melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang keperawatan kesehatan komunitas, keluarga dan gerontik. Penulis juga

memiliki pengalaman menulis buku dan artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional, baik sebagai penulis utama maupun anggota.

Email penulis: yusuf.nurhasanah@gmail.com

SINOPSIS

Perdarahan postpartum merupakan salah satu penyebab utama tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Untuk menanggulangi hal ini, diperlukan alat deteksi dini yang mudah digunakan oleh tenaga kesehatan, kader, maupun ibu hamil. Kartu Skor Deteksi Dini Risiko Perdarahan Postpartum (KSPPP) hadir sebagai solusi praktis untuk mengidentifikasi risiko perdarahan sejak awal. Kartu ini diharapkan dapat membantu proses skrining sehingga ibu hamil yang berisiko tinggi dapat segera memperoleh perawatan yang tepat dan terhindar dari komplikasi serius. Buku ini disusun sebagai pendamping KSPPP, dengan harapan dapat menjadi panduan dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan meningkatkan keselamatan persalinan di Indonesia.

Perdarahan postpartum merupakan salah satu penyebab utama tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Untuk menanggulangi hal ini, diperlukan alat deteksi dini yang mudah digunakan oleh tenaga kesehatan, kader, maupun ibu hamil. Kartu Skor Deteksi Dini Risiko Perdarahan Postpartum (KSPPP) hadir sebagai solusi praktis untuk mengidentifikasi risiko perdarahan sejak awal. Kartu ini diharapkan dapat membantu proses skrining sehingga ibu hamil yang berisiko tinggi dapat segera memperoleh perawatan yang tepat dan terhindar dari komplikasi serius. Buku ini disusun sebagai pendamping KSPPP, dengan harapan dapat menjadi panduan dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan meningkatkan keselamatan persalinan di Indonesia.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-76-0



9

786347

294760